

Buku Referensi

PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

Nyoman Agus Jagat Raya
Rian Maulana Yusup
Iryani Yuni Yastutik
Firmina Theresia Kora



BUKU REFERENSI PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

Ns. Nyoman Agus Jagat Raya, S.Kep., MNS

Ns. Rian Maulana Yusup, S.Kep., M.Kep

Bd. Iryani Yuni Yastutik, SST., M.Kes.

Ns. Firmina Theresia Kora, S.Kep., M.P.H.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

Penulis: Ns. Nyoman Agus Jagat Raya, S.Kep., MNS
Ns. Rian Maulana Yusup, S.Kep., M.Kep
Bd. Iryani Yuni Yastutik, SST., M.Kes.
Ns. Firmina Theresia Kora, S.Kep., M.P.H.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-89972-8-2

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga buku referensi ini dapat tersusun dengan baik. Buku berjudul "Peran Keperawatan dalam Perawatan Pasien dengan HIV/AIDS" ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan panduan praktis bagi perawat, akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perawatan pasien HIV/AIDS. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman praktis dan hasil kajian ilmiah terkini, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan strategi dalam mengelola pasien HIV/AIDS.

Kami menyadari bahwa HIV/AIDS tidak hanya berdampak secara medis, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan spiritual bagi pasien dan keluarga mereka. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang diuraikan dalam buku ini sangat esensial untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta mendukung peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan berbasis bukti.

Melalui penyajian materi yang sistematis mulai dari strategi keperawatan, dukungan psikologis, peran komunitas, hingga pendekatan multidisiplin, buku ini diharapkan mampu memperkaya wawasan dan keterampilan pembaca dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien HIV/AIDS. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, serta kontribusi penting dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I STRATEGI KEPERAWATAN DALAM MENJAGA KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Fenomena Stigma HIV dan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS	3
C. Paradigma Keperawatan terhadap Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS	6
D. Asuhan Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS.....	9
E. Penutup	18
Referensi	19
BAB II DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN DAN KELUARGA PENDERITA HIV/AIDS.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Dukungan Keluarga, Sikap dan Mekanisme Koping	22
C. Kebutuhan Psikologis Penderita HIV / AIDS.....	25
D. Asuhan Keperawatan Komunitas Pada Pandemi COVID-19	29
E. Persepsi Positif Penderita HIV	30
F. Strategi Koping Penderita HIV	32
G. Penutup	36
Referensi	37
BAB III PERAN KOMUNITAS DALAM MENDUKUNG PASIEN HIV/AIDS	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Peran Komunitas dalam Deteksi Dini dan Pencegahan HIV/AIDS	40
C. Dukungan Psikososial dan Penguatan Mental ODHA.....	42
D. Dukungan Psikososial dan Penguatan Mental ODHA.....	43
E. Pendampingan Terapi dan Kepatuhan Pengobatan	45
F. Penanggulangan Stigma dan Diskriminasi	46
G. Keterlibatan Komunitas dalam Kebijakan dan Advokasi	48
H. Studi Kasus dan Praktik Baik	50
I. Tantangan dan Rekomendasi	52
Referensi	55
BAB IV PENDEKATAN MULTIDISIPLIN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN PASIEN	58
A. Pendahuluan.....	58
B. Konsep Dasar HIV/AIDS dan Peran Keperawatan	60
C. Pendekatan Multidisiplin dalam Perawatan HIV/AIDS.....	61
D. Intervensi Keperawatan dalam Tim Multidisiplin.....	64

E. Studi Kasus dan Implementasi Praktik	66
F. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Multidisiplin.....	68
G. Penutup	70
Referensi	73
Profil Penulis	75

BAB I

STRATEGI KEPERAWATAN DALAM MENJAGA KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS

A. Pendahuluan

Human Immunodeficiency Virus (HIV) sudah ada sejak ditemukan kasus pertama kali pada awal 1980-an, dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) telah menjadi salah satu permasalahan kesehatan global yang memerlukan perhatian serius dan ditangani secara komprehensif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah HIV semakin tersebar luas, namun HIV/AIDS masih menjadi tantangan kompleks bagi banyak negara. Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) hingga akhir tahun 2023 melaporkan bahwa 39,9 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia dan apabila dikumulatifkan sejak kemunculan HIV pertama kali di dunia sudah mencapai 88,4 juta orang di seluruh dunia (WHO, 2024).

Upaya global untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS pada tahun 2030 masih menjadi salah satu prioritas kesehatan hampir di sebagian besar negara yang berkorelasi terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, pencapaian tersebut masih memerlukan strategi untuk dapat dikendalikan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan pengobatan dan pencegahan kepada orang dengan HIV (ODHIV) dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) termasuk kepada orang yang berisiko tinggi tertular HIV (Eisinger & Fauci, 2018). Program ini pun masih mendapatkan tantangan karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV dan ODHA.

Stigma dan diskriminasi yang masih melekat di masyarakat. Stigma terhadap ODHIV dan ODHA membuat kesulitan mencari pengobatan dan dukungan untuk mendapat akses layanan kesehatan HIV yang diperlukan sesuai kebutuhan. Tidak

hanya itu, dampak dari fenomena stigma dan diskriminasi adalah angka *lost to follow-up* atau hilangnya pasien HIV/AIDS dalam pemantauan proses pengobatan antiretroviral (ARV) menjadi masalah serius yang mengancam kualitas hidup ODHIV dan/atau ODHA. Beragam alasan terjadinya *lost to follow-up* terapi ARV selain stigma sosial adalah ketidaktahuan tentang pentingnya pengobatan jangka panjang, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan (Wiratama, Raya, & Juniarta, 2023).

Minimnya akses terhadap layanan kesehatan HIV juga menjadi hambatan utama dalam menekan angka kasus baru, terlebih ketika masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022 yang terjadi di Indonesia (Wiratama, Raya, & Juniarta, 2023). Di banyak daerah, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas, fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan tes HIV, konseling, dan terapi ARV masih sangat terbatas. Hambatan ini semakin diperburuk oleh kurangnya distribusi ARV yang merata, yang menyebabkan banyak ODHIV/ODHA tidak mendapatkan pengobatan sehingga berdampak pula terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini menjadi tantangan pada permasalahan HIV di Indonesia. Hal ini yang terpikirkan untuk mengembangkan pendekatan manajemen multimodal dan alternatif terapeutik untuk meningkatkan sikap dan perilaku dalam mengakses layanan kesehatan HIV di Indonesia di masa depan (Jocelyn et al., 2024).

Dalam menghadapi tantangan ini, tenaga kesehatan, terutama perawat sebagai tenaga kesehatan garda terdepan ke pasien, memiliki peran yang sangat fundamental dan penting dalam menjaga kualitas hidup ODHIV/ODHA. Perawat tidak hanya berperan dalam aspek merawat klinis, seperti pemantauan pemberian terapi dan manajemen gejala pasien HIV/AIDS, tetapi juga dalam aspek psikososial yang mencakup dukungan emosional dan edukasi kepada ODHIV/ODHA dan keluarganya. Pendekatan berbasis *evidence-based nursing* merupakan dasar bagi perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengurangi stigma, serta membantu

ODHIV/ODHA dalam mengelola kondisi kesehatan mereka secara optimal, sehingga tercapainya kualitas hidup yang baik.

Bab ini disusun sebagai referensi bagi tenaga kesehatan khususnya perawat, akademisi, dan pihak terkait yang ingin memahami lebih dalam mengenai tantangan serta strategi dalam menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Ulasan bab ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan bagi ODHIV/ODHA dan berkontribusi dalam pencapaian target eliminasi kasus HIV/AIDS secara nasional dan global.

B. Fenomena Stigma HIV dan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS

Stigma terhadap ODHIV di masyarakat memunculkan beragam permasalahan bagi ODHIV/ODHA itu sendiri. Stigma HIV ini muncul di masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa satu-satunya penyebab orang terkena HIV karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat, seperti hubungan seksual berisiko tinggi, pekerja seks, atau penggunaan narkoba suntik. Persepsi ini menyebabkan munculnya prejudis dan stereotip yang mengarah pada diskriminatif terhadap ODHIV/ODHA, baik dalam lingkungan sosial, tempat kerja, maupun dalam layanan kesehatan (Andersson et al., 2019). Tidak jarang yang terjadi di masyarakat sampai dengan tindakan pengucilan ODHIV/ODHA apabila diketahui oleh masyarakat. Alasan inilah yang menyebabkan ODHIV/ODHA memilih untuk menutup status HIV karena takut mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh masyarakat, sehingga lebih memilih untuk tidak mengakses layanan kesehatan HIV, termasuk mendapatkan pengobatan terapi ARV (Raya & Nilmanat, 2021).

Fenomena stigma HIV tidak hanya terjadi di masyarakat, bahkan tindakan tersebut juga terjadi di fasilitas layanan kesehatan, salah satunya sikap prejudis terhadap ODHIV yang mengakses layanan kesehatan walaupun universal preception

telah diterapkan pada tenaga kesehatan (Feyissa, Lockwood, Woldie, & Munn, 2019). Tidak sedikit tenaga kesehatan memiliki persepsi negatif terhadap ODHIV/ODHA ketika mereka memanfaatkan layanan kesehatan HIV, namun cenderung yang terjadi adalah sikap prejudis, stereotip, bahkan diskriminasi dalam pelayanan medis. Bentuk diskriminasi ini dapat berupa penolakan pelayanan, perlakuan yang tidak adil, hingga kurangnya empati dalam memberikan perawatan. Stigma HIV pada kalangan tenaga kesehatan muncul karena belum mendalam pemahaman mengenai HIV/AIDS, serta ketakutan karena memiliki risiko penularan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan sebagai pendidik sebaya dan pemberian promosi kesehatan (Feyissa, Lockwood, Woldie, & Munn, 2019). Apabila dasar dalam melayani pasien HIV/AIDS ini tidak dipahami dan diimplementasikan dengan baik dalam bentuk pelayanan kesehatan yang memadai, sangat dipastikan ODHIV/ODHA merasa tidak nyaman dalam mengakses fasilitas kesehatan, hingga akhirnya memunculkan dampak-dampak negatif lainnya dari stigma HIV ini.

HIV/AIDS tidak hanya berdampak pada status kesehatan yang memburuk apabila tidak ditangani dengan menjalani terapi ARV, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial bahkan melebihi dampak fisik yang dirasakan ODHOV/ODHA. Menurut studi literatur yang dilakukan Raya (2019) memaparkan dampak dari stigma HIV diantaranya:

1. Terjadi peningkatan depresi akibat dari terbentuknya mekanisme koping negatif pada diri ODHIV/ODHA.
2. Kehidupan sosial mencakup di keluarga, tempat kerja, sosial masyarakat menjadi terganggu hingga cenderung menarik diri.
3. Kehidupan ekonomi menjadi terganggu karena kesulitan mendapatkan akses pekerjaan atau ketakutan ditolak untuk mencari pekerjaan.
4. Terjadi penurunan dalam mengakses layanan kesehatan HIV, termasuk risiko terjadinya *lost to follow up*.

5. Ketidapatuhan pengobatan terhadap ARV semakin meningkat.
6. ODHIV/ODHA cenderung akan menjauh pergi ke daerah yang tidak banyak orang mengetahui status HIVnya.
7. Gangguan kesehatan mental.
8. Kualitas hidup semakin menurun.

Dampak dari stigma HIV tidak hanya *enacted stigma* (stigma nyata yang dialami oleh ODHIV/ODHA), namun juga terjadi *anticipated stigma* (pikiran dan ketakutan ODHIV/ODHA sendiri untuk mengantisipasi munculnya stigma) dan *internalized stigma* (ODHIV/ODHA melakukan stigma internal pada diri sendiri) (Raya, Harjana, Purnamasidhi, & Sulistiowati, 2024). Dampak dari ketiga jenis stigma HIV tersebut akan menurunkan akses ke layanan kesehatan HIV dan ketidapatuhan pengobatan ARV, sehingga dapat meningkatkan *viral load*, menurunkan CD4, memperluas penyebaran HIV, dan menurunkan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS (Green et al., 2020; Perger et al., 2025).

Stigma HIV memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup ODHA dan telah dibuktikan dari berbagai penelitian. Ketika seseorang mengalami stigma HIV dan diskriminasi, seseorang tersebut cenderung mengalami stres yang berkepanjangan hingga depresi, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologisnya. Stigma HIV yang membuat ODHIV terhambat dalam mengakses pengobatan ARV akan menyebabkan kondisi kesehatan ODHIV semakin memburuk dan tak jarang memunculkan infeksi oportunistik hingga ke stadium AIDS. Oleh karena itu, pengurangan stigma HIV sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup ODHIV/ODHA. Beberapa cara yang dapat dilakukan guna mengatasi fenomena stigma HIV ini melalui kampanye edukasi HIV/AIDS, pendekatan berbasis empati dalam layanan kesehatan HIV, serta perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan komprehensif. Lingkungan yang kondusif tanpa stigma HIV, menciptakan suasana yang nyaman bagi ODHIV dalam mengakses layanan kesehatan HIV,

sehingga meningkatkan CD4, menurunkan *viral load* hingga tidak terdeteksi, maka kualitas hidup ODHIV/ODHA akan semakin baik.

C. Paradigma Keperawatan terhadap Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS

Ilmu keperawatan berkontribusi besar dalam menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS, sehingga ODHIV/ODHA dapat menjalani kehidupan seperti orang non-HIV lainnya. Pondasi dasar ilmu keperawatan dalam menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS terpatri melalui penerapan dari paradigma keperawatan yang mencakup empat komponen, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan.

1. Manusia (*Human*)

Manusia dipandang sebagai individu yang memiliki aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. ODHIV/ODHA bukan hanya sekadar individu yang sedang terdiagnosis penyakit, tetapi juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan dukungan dan penghormatan terhadap hak-haknya. Perawat memiliki peran dalam memahami kebutuhan unik pasien serta membantu mereka mencapai kesejahteraan maksimal melalui pemahaman individu secara personal dengan cara pengkajian dan memfasilitasi kebutuhan ODHIV/ODHA dalam perannya di masyarakat.

2. Kesehatan (*Health*)

Kesehatan dalam paradigma keperawatan bukan hanya mencoba untuk mengobati penyakit tetapi juga memerhatikan kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial pasien HIV/AIDS. ODHIV/ODHA dapat meningkatkan kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Edukasi mengenai terapi antiretroviral (ART) dan gaya hidup sehat menjadi contoh pendekatan

yang dapat dilakukan dan hal tersebut sangat penting untuk memperpanjang harapan hidup pasien HIV/AIDS.

3. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan memainkan peran besar dalam kehidupan pasien HIV/AIDS, baik lingkungan fisik maupun sosial. Bentuk dari paradigma lingkungan dalam konteks menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS adalah dukungan keluarga, masyarakat, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang ramah terhadap pasien HIV/AIDS. Hal tersebut sangat menentukan kualitas hidup ODHV/ODHA dalam menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Peran dari Perawat dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dalam mengurangi stigma HIV di masyarakat, salah satunya dengan melakukan kampanye stop stigma HIV.

4. Keperawatan (*Nursing*)

Keperawatan dengan profesi yang dimiliki tentu etika profesi harus diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan asuhan yang holistik kepada pasien HIV/AIDS. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan mencakup manajemen gejala, dukungan psikososial, advokasi, serta pemberdayaan ODHV/ODHA dalam mengelola kesehatan sendiri. Selain itu, pendekatan berbasis *evidence-based nursing* sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Paradigma keperawatan memberikan kerangka kerja yang kuat dalam menerapkan asuhan keperawatan profesional guna meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Hubungan antara manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan wajib dipahami oleh perawat, sehingga perawat dapat memberikan asuhan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien HIV/AIDS.

Melalui pendekatan ini, pasien HIV/AIDS dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, produktif, bermakna, dan sehat optimal.

Paradigma keperawatan juga memerhatikan aspek-aspek yang ada pada kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS. Beberapa teori yang menjelaskan komponen-komponen dari kualitas hidup, khususnya pada pasien HIV/AIDS yaitu:

1. World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)

Komponen yang terdapat pada WHOQOL adalah fisik, psikologis, kemandirian, sosial, lingkungan, spiritualitas.

- a. Fisik mencakup tingkat energi, rasa sakit, kelelahan, gangguan tidur, dan kapasitas untuk beraktivitas.
- b. Psikologis mencakup rasa kepuasan hidup, harga diri, tingkat kecemasan, depresi, dan fungsi kognitif.
- c. Kemandirian mencakup aktivitas sehari-hari dengan mengukur kemampuan dan tingkat ketergantungan.
- d. Sosial mencakup hubungan interpersonal, dukungan sosial, dan penerimaan oleh lingkungan.
- e. Spiritualitas mencakup tingkat kepercayaan diri, makna hidup, dan kepuasan spiritual.

2. Hirarki Kebutuhan Maslow

Komponen dari kebutuhan Maslow yaitu fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi.

- a. Fisiologis seperti kebutuhan makan minum (nutrisi), istirahat, rekreasi, kesehatan fisik.
- b. Keamanan seperti kebutuhan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial.

- c. Cinta dan rasa memiliki seperti kebutuhan memperoleh dukungan dan keterikatan rasa memiliki bersama teman, pasangan, keluarga, dan komunitas.
- d. Harga diri seperti kebutuhan dihargai dan mendapatkan perilaku adil serta tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.
- e. Aktualisasi diri seperti pencapaian yang diperoleh berdasarkan potensi penuh dan gigih.

D. Asuhan Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS

Perawat dalam menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS dapat diimplementasikan dalam penerapan paradigma keperawatan melalui asuhan keperawatan. Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi kebutuhan pasien HIV/AIDS. Pemberian asuhan keperawatan yang akan diulas ini berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS mencakup pengkajian, diagnosis, luaran-intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas hidup pasien HIV/AIDS terdiri dari kondisi kualitas fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

- a. Pengkajian fisik

- i. Riwayat kesehatan umum dan status kesehatan saat ini. Hal ini juga mencakup pengkajian identitas pasien, kondisi umum, keluhan utama (jika ada), riwayat pengobatan, riwayat kesehatan, dan tanda-tanda vital.
- ii. Riwayat gejala mengkaji tentang riwayat kekambuhan atau kemunculan gejala serta mekanisme strategi untuk manajemen gejala.
- iii. Status nutrisi mengkaji berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, riwayat asupan makanan dan minuman, dan ada tidaknya penurunan berat badan.
- iv. Riwayat infeksius termasuk didalamnya kondisi imunitas salah satunya dengan mengecek *viral load* dan CD4. Selain itu, perhatikan kemunculan infeksi oportunistik.
- v. Riwayat pengobatan ARV dengan mengkaji ada tidaknya riwayat putus obat, riwayat *lost to follow up*, serta jadwal konsumsi ARV.
- b. Pengkajian psikologis
 - i. Kesehatan mental mencakup pengkajian tingkat cemas, stres, depresi, hingga risiko gangguan mental dan kejiwaan lainnya.
 - ii. Pengkajian mekanisme koping yang mencakup cara atau strategi pasien dalam menghadapi HIV dalam tubuh dan masalah terkait lainnya.
 - iii. Dukungan emosional dengan mengkaji ada atau tidaknya dukungan dari keluarga, teman, kerabat, tenaga kesehatan, masyarakat sekitarnya.
- c. Pengkajian sosial
 - i. Mengkaji ada atau tidaknya pasien mengalami stigma HIV. Kaji lebih dalam tentang jenis stigma, situasi dan kondisi terjadinya stigma, dan dampak yang dialami pasien.
 - ii. Dukungan sosial dengan mengkaji ada atau tidaknya dukungan yang membantu pasien yang bersumber dari keluarga, teman, kerabat, masyarakat sekitarnya.

- iii. Status ekonomi mengkaji terkait pekerjaan yang dijalani saat ini, kebutuhan hidup terkait finansial, sumber pendapatan lain, kemampuan bertahan secara ekonomi dengan kondisi sebagai pasien.
- d. Pengkajian spiritual
 - i. Mengkaji tentang makna hidup dan harapan hidup pasien. Kaji perspektif pasien memandang hidup dengan status HIV positif serta harapan yang diinginkan selama hidup.
 - ii. Mengkaji agama dan keyakinan, termasuk cara dan praktik agama dan keyakinan pasien dalam menjalani status sebagai HIV positif.
- e. Pengkajian lainnya yang berfokus pada kualitas hidup pasien HIV/AIDS seperti tingkat kemandirian dalam memenuhi *activity daily living*, kepemilikan asuransi kesehatan, penilaian terhadap diri sendiri termasuk kepuasan diri dan harapan di masa depan.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan harus berdasarkan *problem*, *etiology*, dan *symptom* yang muncul dari pasien. Setiap pasien memiliki masalah yang berbeda-beda maka masalah keperawatan prioritas pun kemungkinan akan berbeda antar pasien. Masalah keperawatan yang mungkin muncul dari pengkajian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Risiko infeksi (D.0142)
- b. Nyeri akut (D.0077)
- c. Nyeri kronis (D.0078)
- d. Defisi nutrisi (D.0019)
- e. Keletihan (D.0057)
- f. Gangguan integritas kulit/jaringan (D.0129)
- g. Ansietas (D.0080)

- h. Keputusasaan (D.0088)
- i. Koping tidak efektif (D.0096)
- j. Isolasi sosial (D.0121)
- k. Harga diri rendah kronis (D.0086)
- l. Defisit pengetahuan (D.0111)
- m. Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan (D.0112)
- n. Distres spiritual (D.0082)
- o. Defisit perawatan diri (D.0109)
- p. Ketidakpatuhan [terhadap regimen terapeutik] (D.0114)

Apabila pasien mengalami gejala-gejala yang disebabkan infeksi oportunistik, maka masalah keperawatan akan cenderung kepada kategori fisiologis yang mencakup subkategori respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Apabila pasien mengalami gejala-gejala yang disebabkan oleh lingkungan, maka masalah keperawatan cenderung pada subkategori keamanan dan proteksi.

3. Luaran Keperawatan

Luaran keperawatan adalah target capaian yang ditentukan perawat berdasarkan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan timed*). Luaran keperawatan harus disesuaikan dengan diagnosis keperawatan, termasuk faktor yang berhubungan serta gejala mayor dan minor yang muncul. Berikut adalah beberapa luaran keperawatan yang disesuaikan untuk menjaga kualitas hidup pasien HIV/AIDS:

- a. Status imun (L.14133) mencakup indikator integritas kulit, integritas mukosa, titer antibodi, imunisasi, kadar sel T4, kadar sel T8, CD4, viral load, sel darah putih, dan infeksi oportunistik.

- b. Kontrol gejala (L.14127) mencakup indikator kemampuan memonitor tingkat durasi, keparahan, frekuensi, variasi, tindakan pencegahan, dan kemampuan manajemen gejala lainnya.
- c. Tingkat infeksi (L.14137) mencakup indikator yang mengarah kepada penyebab terjadinya infeksi dapat menurun dan perlu pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium terkait infeksi seperti kultur sel darah putih, urin, sputum, área luka, dan feses.
- d. Tingkat nyeri (L.08066) mencakup indikator yang mengarah kepada keluhan nyeri secara verbal menurun, secara objectif seperti frekuensi nadi, pola napas, tekanan darah, dan fisiologis lainnya yang berkaitan dengan nyeri menjadi menurun.
- e. Tingkat kelelahan (L.05046) mencakup indikator secara verbal dan tanda-tanda yang mengarah kepada penurunan kelelahan.
- f. Status nutrisi (L.03030) mencakup indikator tentang keadekuatan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh pasien dengan indeks massa tubuh menjadi salah satu indikator.
- g. Tingkat ansietas (L.09093) mencakup indikator verbalisasi dan perilaku yang mengarah pada penurunan tingkat kecemasan.
- h. Status koping (L.09086) mencakup indikator kemampuan manajemen koping, status psikologis yang membaik, partisipasi sosial, dan perilaku yang sesuai.
- i. Tingkat kepatuhan (L.12110) mencakup indikator verbalisasi dan perilaku yang mengarah kepada kepatuhan terhadap pengobatan.
- j. Tingkat pengetahuan (L.12111) mencakup indikator verbalisasi dan perilaku yang mengarah kepada peningkatan terhadap pengetahuan (kognitif).
- k. Perawatan diri (L.11103) mencakup indikator peningkatan kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas dalam proses perawatan diri.

- l. Penerimaan (L.09082) mencakup indikator yang dinyatakan secara verbal dan perilaku dalam upaya menerima pemahaman untuk menurunkan kecemasan terhadap diagnosis HIV positif.
- m. Manajemen kesehatan (L.12104) mencakup indikator dalam meningkatkan cara atau strategi ke dalam suatu program atau aktivitas untuk tercapainya kesehatan yang optimal, baik disampaikan secara verbal atau ditunjukkan secara perilaku.
- n. Psikospiritual (L.09084) mencakup indikator untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri, konsep diri membaik, mampu memaknai hidup, dan tidak menunjukkan ciri gelisah, depresi, takut, bahkan bunuh diri.

4. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan luaran keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Intervensi keperawatan juga mencakup rencana tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Berikut adalah beberapa gambaran intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah fisik, psikis, sosial, dan spiritual dari pasien dengan HIV/AIDS:

- a. Pencegahan infeksi (I.14539) dengan mengidentifikasi dan menurunkan risiko terserang infeksi oportunistik. Kolaborasi jika infeksi telah terjadi sehingga diperlukan farmakologi.
- b. Manajemen imunisasi/vaksinasi (I.14508) dengan mengidentifikasi dan mengelola pemberian kekebalan tubuh bagi ODHIV namun harus berkonsultasi dengan dokter. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dan masuk ke tahap AIDS.
- c. Perawatan integritas kulit (I.11353) dengan berfokus pada merawat kulit hingga jaringan apabila pasien terjadi lesi akibat infeksi atau luka dengan memerhatikan dan menjaga keutuhan, kelembaban, dan mencegah infeksi berlanjut.

- d. Manajemen nutrisi (I.03119) dengan mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi pasien seimbang sesuai dengan perhitungan indeks massa tubuh dan kebutuhan metabolisme tubuh.
- e. Dukungan perawatan diri (I.11348) berfokus dengan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perawatan diri sesuai dengan bagian yang defisit yang dialami oleh pasien.
- f. Manajemen energi (I.05178) dengan mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari untuk mencegah terjadinya kelelahan.
- g. Manajemen nyeri (I.08238) dengan mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik dan emosional pasien baik nyeri akut atau nyeri kronis yang berfokus pada penurunan skala nyeri dan diverbalisasikan nyeri menurun.
- h. Reduksi ansietas (I.09314) dengan meminimalkan kondisi kecemasan pasien terhadap situasi dan kondisi yang membuat keterpurukan. Kondisi ini dapat diverbalkan dan ditunjukkan secara perilaku oleh pasien sehingga terjadi tidak terjadi kecemasan (atau dapat terkontrol baik) terhadap status HIV positif.
- i. Edukasi kesehatan (I.12383) berfokus untuk memberikan edukasi kesehatan tentang HIV dan AIDS khususnya pencegahan penyebaran HIV dan edukasi untuk tidak menularkan HIV melalui penggunaan alat kontrasepsi.
- j. Edukasi program pengobatan (I.12441) berfokus pada pemberian edukasi untuk mengetahui jadwal konsumsi ARV, fungsi ARV, dan efek samping yang mungkin muncul.
- k. Promosi koping (I.09312) sebagai upaya untuk meningkatkan kognitif dan perilaku pasien dalam merespon stresor dan mencegah pikiran negatif yang berujung pada perilaku maladaptif.
- l. Manajemen perilaku (I.12463) diberikan kepada pasien apabila pasien sudah menunjukkan perilaku negatif, tidak terkontrol, dan berbahaya,

sehingga tindakan diskusi dengan tenang, mencari solusi, dan melibatkan keluarga adalah intervensi yang dapat diberikan.

- m. Manajemen isolasi (I.14509) diberikan kepada pasien yang menarik diri karena dampak dari stigma HIV. Lakukan identifikasi penyebab dan risiko isolasi, kemudian mengelola psikologis pasien untuk dapat kembali bersosialisasi.
- n. Dukungan emosional (I.09256) dengan memfasilitasi penerimaan kondisi emosional selama menghadapi stres. Fokus tindakan ini pada eksplorasi perasaan dan mendampingi dalam mendapatkan emosi yang stabil dan terkontrol. Lakukan perujukan apabila emosi tidak terkontrol dan cenderung maladaptif.
- o. Promosi harapan (I.09307) mendukung pasien yang sudah stabil dalam menemukan harapan hidup. Latih pasien untuk cara mengembangkan spiritual diri dengan mempraktikkan kebutuhan spiritual menuju peningkatan tujuan harapan hidup.

5. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan dilakukan apabila sudah menetapkan luaran dan intervensi keperawatan. Dalam pelaksanaan implementasi keperawatan harus secara jelas menunjukkan waktu pelaksanaan, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien, evaluasi singkat subjektif dan objektif pasien saat diberikan satu tindakan intervensi. Selain itu, apabila melakukan intervensi kolaborasi dalam pemberian terapi farmakologi, maka penting untuk menerapkan 8 benar. Implementasi tindakan keperawatan harus terdokumentasikan dan sesuai dengan rencana intervensi yang telah dibuat sebelumnya.

6. Evaluasi Keperawatan

Setelah melakukan implementasi keperawatan kepada pasien HIV/AIDS guna menjaga kualitas hidup, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Hal-hal yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menghambat implementasi harus dikaji kembali. Beberapa faktor yang menghambat keberhasilan implementasi seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif (tidak adanya dukungan sosial, stigma HIV), kepatuhan pasien sendiri termasuk kepatuhan pengobatan ARV, dan keterbatasan sumber daya manusia dan alat penunjang dalam pelayanan kesehatan HIV.
- b. Modifikasi intervensi dilakukan apabila intervensi sebelumnya belum maksimal memberikan dampak luaran yang diharapkan. Gunakan metode komunikasi yang lebih efektif dalam menyepakati intervensi modifikasi selanjutnya pada ODHIV/ODHA beserta keluarga/kerabatnya.
- c. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain apabila implementasi secara mandiri perawat belum cukup memberikan capaian luaran yang optimal pada pasien. Rujukan menjadi sangat diperlukan guna tercapainya asuhan keperawatan yang komprehensif, seperti kepada psikolog, fisioterapi, atau ahli gizi.
- d. Evaluasi pula motivasi pasien dalam menjalani proses pengobatan. Pasien mungkin saja terjadi demotivasi karena proses pengobatan ARV adalah seumur hidup, sehingga memahami keinginan dan motivasi pasien harus tetap dievaluasi setiap harinya.
- e. Pemantauan respon pasien dari hari ke hari yang berguna untuk mengetahui tindakan intervensi yang lebih tepat selama proses perawatan.

Keberhasilan implementasi keperawatan perlu dievaluasi secara berkala dengan tujuan agar perawat mampu menganalisis hambatan, memodifikasi pendekatan,

dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan terbaik yang berkelanjutan.

E. Penutup

Fenomena HIV/AIDS masih menjadi perhatian global tanpa terkecuali di Indonesia. Kasus yang meningkat hampir disetiap tahunnya. Pendataan kasus baru, termasuk mendata pasien yang *lost to follow up* menjadi penuh tantangan karena ODHIV mulai minim mengakses layanan kesehatan HIV, salah satunya dampak dari stigma HIV. Stigma HIV ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi sosial hingga hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan HIV. Dampak stigma HIV mencakup aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi ODHIV/ODHA. Kualitas hidup pasien HIV/AIDS juga dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual, sehingga stigma dan kualitas hidup saling berkorelasi. Pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup ODHIV yang mencakup manajemen medis yang optimal, dukungan psikososial, kebijakan anti-diskriminasi, akses ke layanan kesehatan HIV, dan penguatan mekanisme koping pasien. Pengejawantahan proses keperawatan berdasarkan *evidence-based nursing* dalam asuhan keperawatan pasien HIV/AIDS sangat penting untuk meningkatkan serta menjaga kualitas hidup ODHIV/ODHA. Strategi berbasis bukti yang mencakup manajemen gejala, dukungan psikososial, pendekatan holistik, intervensi nutrisi, kepatuhan pengobatan, serta peningkatan akses layanan kesehatan telah terbukti efektif dalam membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

Referensi

- Andersson, G. Z., Reinius, M., Eriksson, L. E., Svedhem, V., Esfahani, F. M., Deuba, K., Rao, D., Lyatuu, G. W., Giovenco, D., & Ekström, A. M. (2020). Stigma reduction interventions in people living with HIV to improve health-related quality of life. *The Lancet. HIV*, 7(2), e129–e140. [https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(19\)30343-1](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(19)30343-1)
- Eisinger, R. W., & Fauci, A. S. (2018). Ending the HIV/AIDS Pandemic. *Emerging Infectious Diseases*, 24(3), 413–416. <https://doi.org/10.3201/eid2403.171797>
- Feyissa, G. T., Lockwood, C., Woldie, M., & Munn, Z. (2019). Reducing HIV-related stigma and discrimination in healthcare settings: A systematic review of quantitative evidence. *PloS one*, 14(1), e0211298. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211298>
- Green, H. D., Weeks, M. R., Berman, M., Salvi, A., Gonzalez, R., Rohena, L., Ferguson, A., & Li, J. (2020). The Impact of Perceptions of Community Stigma on Utilization of HIV Care Services. *Journal of racial and ethnic health disparities*, 7(2), 383–391. <https://doi.org/10.1007/s40615-019-00667-9>
- Jocelyn, Nasution, F. M., Nasution, N. A., Asshiddiqi, M. H., Kimura, N. H., Siburian, M. H. T., Rusdi, Z. Y. N., Munthe, A. R., Chairenza, I., Ginting Munthe, M. C. F. B., Sianipar, P., Gultom, S. P., Simamora, D., Uswanas, I. R., Salim, E., Khairunnisa, K., & Syahputra, R. A. (2024). HIV/AIDS in Indonesia: current treatment landscape, future therapeutic horizons, and herbal approaches. *Frontiers in public health*, 12, 1298297. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1298297>
- Perger, T., Davtyan, M., Foster, C., Evangeli, M., Berman, C., Kacanek, D., Puga, A. M., Sekidde, S., & Bhopal, S. (2025). Impact of HIV-Related Stigma on Antiretroviral Therapy Adherence, Engagement and Retention in HIV Care, and Transition to Adult HIV Care in Pediatric and Young Adult Populations Living With HIV: A Literature Review. *AIDS and behavior*, 29(2), 497–516. <https://doi.org/10.1007/s10461-024-04534-5>
- PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI
- PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI

- PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI
- Raya, N. A. J. (2019). Experience and Management of Stigma Among Persons Infected With HIV in Bali, Indonesia. Prince of Songkla University. Retrieved from https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/13428/1/4375_29.pdf
- Raya, N. A. J., & Nilmanat, K. (2021). Experience and management of stigma among persons living with HIV in Bali, Indonesia: A descriptive study. *Japan journal of nursing science : JJNS*, 18(2), e12391. <https://doi.org/10.1111/jjns.12391>
- Raya, N. A. J., Harjana, N. P. A., Purnamasidhi, C. A. W., & Sulistiowati, N. M. D. (2024). *HIV dan AIDS Bagi Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan*. Bondowoso: KHD Production
- Wiratama, I. P. S., Raya, N. A. J., & Juniarta, I. G. N.. (2023). The Experiences of People Living with HIV in Seeking HIV Health Services During Covid-19 Pandemic in Denpasar. *NurseLine Journal*, 8(1), 24-33. doi:10.19184/nlj.v8i1.36768
- World Health Organization. (2024). Summary of the global HIV epidemic in 2023. Retrieved from <https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids>

BAB II

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN DAN KELUARGA PENDERITA HIV/AIDS

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini dihadapkan pada peningkatan kasus HIV/AIDS, termasuk di kalangan remaja. Jumlah kasus dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023. Kasus HIV/AIDS tertinggi pada rentang usia 30-39 tahun, yang didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 62% dan perempuan 32%. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah merupakan sekelompok penyakit yang disebabkan oleh penurunan imunitas pada tubuh manusia. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh keberadaan virus HIV yang hidup dan berkembang dalam empat cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina, dan air susu ibu (Brunner & Suddarth, 2015; Nomiko dkk., 2021).

Berbagai dampak ketika seseorang terdiagnosa HIV/AIDS, seperti kecemasan, dihantui perasaan bersalah, stress, depresi yang kemudian berlanjut ke percobaan bunuh diri. Lebih lanjut ODHA sering dihadapkan pada berbagai dampak psikologis lainnya seperti merasa tidak dihargai, hidupnya penuh dengan keputusasaan, ketidakberdayaan, perasaan hampa, tidak berarti, kurang inisiatif, acuh tak acuh, bosan, tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri (Nisak, 2024).

Penderita ODHA dalam menghadapi dampak negatif dari keadaan yang dirasakannya perlu mengahadapinya sendiri, ia harus melakukan mekanisme koping dengan baik menuju arah yang adaptif (Nomiko dkk., 2021; Siyoto dkk., 2016). Setiap penderita ODHA memiliki mekanisme koping tersendiri dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, penggunaan mekanisme koping yang

adaptif bertujuan untuk menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakitnya (Salami dkk., 2021). Bagi penderita ODHA penggunaan strategi koping terfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah ke arah positif (Priharwanti & Raharjo, 2017).

Tantangan bagi penderita ODHA diantaranya adalah perubahan kesehatan yang kemudian diikuti oleh perubahan sosial ekonomi, demikian halnya dengan anggota keluarga. Dukungan keluarga memegang peranan penting bagi penderita ODHA dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi yang dialaminya. Dukungan bagi penderita ODHA dapat diterima dari keluarga atau anak-anaknya. Selain itu tantangan lainnya dapat berupa stigma negatif dari masyarakat (Pooroe dkk., 2023).

B. Dukungan Keluarga, Sikap dan Mekanisme Koping

Dukungan keluarga mencakup berbagai bentuk bantuan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang diberikan dalam bentuk penyampaian informasi, dukungan emosional, serta kehadiran yang berdampak positif bagi penderita ODHA. Dengan adanya dukungan dari keluarga, penderita ODHA akan merasa lebih diperhatikan, sehingga dapat memperkuat kondisi mental mereka (Smet, 2014). Menurut Friedman (2010), dukungan keluarga berperan dalam mencegah stres pada penderita ODHA serta memberikan dorongan semangat dan motivasi, yang pada akhirnya dapat membantu mereka merasa lebih terhibur (Nomiko dkk., 2021).

Dukungan keluarga yang positif terhadap penderita ODHA dapat berkontribusi dalam meningkatkan *self-esteem* mereka. Sebaliknya, dukungan yang negatif justru dapat berdampak buruk dan meningkatkan risiko depresi pada penderita ODHA. Setiap bentuk dukungan sangat penting, terutama bagi anggota keluarga yang sedang mengalami kondisi kesehatan yang serius. Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dkk. (2018) menunjukkan bahwa salah satu bentuk

dukungan yang sangat diharapkan oleh penderita adalah penyediaan tempat tinggal setelah mereka didiagnosis HIV. Selain itu, layanan dukungan serta penyediaan informasi menjadi aspek utama dalam memperkuat mekanisme koping pasien (Nomiko dkk., 2021).

Elemen dukungan keluarga yang memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan mental pasien HIV/AIDS terutama meliputi dukungan emosional, seperti ekspresi kasih sayang dari keluarga, kemampuan berbagi perasaan, perasaan memiliki peran penting dalam keluarga, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat elemen instrumental yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, serta dukungan keluarga saat pasien mengalami sakit (Amiya dkk., 2014). Sebagai makhluk yang mampu beradaptasi, manusia mengelola stres melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk mekanisme koping. Mekanisme koping merupakan strategi individu dalam beradaptasi terhadap perubahan dan merespons situasi yang dianggap mengancam. Menurut Hawari (2016), mekanisme koping terbagi menjadi dua jenis, yaitu *koping adaptif* dan *koping maladaptif*.

Koping adaptif adalah strategi yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, pembelajaran, serta pencapaian tujuan. Contohnya meliputi berbicara dengan orang lain, menyelesaikan masalah secara efektif, melakukan teknik relaksasi, menjaga keseimbangan dalam aktivitas, dan melakukan kegiatan yang konstruktif. Sebaliknya, *koping maladaptif* merupakan strategi yang dapat menghambat fungsi integrasi, mengurangi otonomi, serta cenderung menciptakan ketergantungan terhadap lingkungan. Contohnya termasuk makan secara berlebihan atau justru tidak makan, bekerja secara berlebihan, serta menghindari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Koping yang adaptif berperan penting dalam mencegah gangguan kesehatan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Nursalam, 2020). Selain itu, koping

adaptif membantu individu dalam mengurangi beban yang diterima tubuh serta mengelola stres secara lebih efektif (Hawari, 2016). Sebaliknya, mekanisme koping yang maladaptif sering kali muncul akibat perasaan tidak berharga yang timbul dari penolakan keluarga serta stigma yang diberikan oleh masyarakat (Siyoto dkk., 2016).

Istilah *dukungan sosial* merujuk pada bentuk kenyamanan, penghargaan, kepedulian, serta bantuan yang diterima seseorang dari individu lain maupun organisasi (Prasetya dkk., 2024). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Windarti et al. (2022), yang menunjukkan bahwa ODHA memiliki berbagai harapan terhadap kondisi kesehatannya. Dukungan yang diharapkan meliputi penerimaan dari keluarga tanpa diskriminasi, kesediaan keluarga untuk merawat ODHA di rumah, serta pemenuhan kebutuhan emosional, motivasi, dan bantuan dalam pengobatan guna mendukung proses pemulihan mereka (Djumadi & Gobel, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Lee, Detels, Rotheram-Borus, & Duan (2018) mengungkapkan bahwa ODHA yang menerima dukungan sosial dalam jumlah yang lebih besar secara signifikan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah serta mengalami lebih sedikit permasalahan. Sebaliknya, ODHA yang mendapatkan dukungan sosial dalam jumlah yang lebih sedikit lebih rentan mengalami depresi dan menghadapi berbagai masalah lainnya. Sejalan dengan temuan tersebut, Sun et al. (2019) mengungkapkan bahwa keterbatasan dukungan sosial serta minimnya fungsi keluarga dapat menimbulkan rasa kesendirian dan kesepian pada ODHA. Rasa kesepian ini berdampak negatif pada kondisi psikososial mereka. Oleh karena itu, ODHA yang mendapatkan dukungan sosial yang lebih baik serta perhatian yang memadai cenderung terhindar dari dampak psikososial yang merugikan.

Dukungan sosial berperan sebagai sumber motivasi dan dorongan bagi ODHA untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Bentuk

dukungan ini mencakup dorongan untuk menjalani terapi ARV secara tepat, pemahaman terhadap kondisi emosional yang dialami, serta penyediaan tempat untuk berbagi keluh kesah sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dukungan sosial yang diterima oleh ODHA berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan terhadap status kesehatan mereka, membentuk pola pikir yang lebih positif dalam menjalani kehidupan, serta memberikan rasa aman dengan mengetahui ke mana mereka dapat mencari pertolongan ketika dibutuhkan.

Dampak positif dari dukungan sosial juga memengaruhi kondisi fisik ODHA, menjadikan mereka lebih sehat secara keseluruhan. Peran utama dukungan sosial adalah sebagai penguat dan penolong, di mana dukungan yang paling dibutuhkan adalah keberadaan seseorang yang bersedia mendengarkan, memahami tanpa prasangka, serta tidak bersikap diskriminatif. Selain itu, ODHA juga membutuhkan rasa aman, penghargaan, serta dukungan instrumental seperti bantuan finansial dan akses terhadap informasi yang relevan (Nisak & Liyanovitasari, 2024).

C. Kebutuhan Psikologis Penderita HIV / AIDS

Spiritualitas merupakan ekspresi dari makna serta tujuan hidup yang mencerminkan manifestasi terdalam dari diri seseorang. Individu mengekspresikan spiritualitas melalui kemampuan unik mereka dalam merenung, berpikir secara mendalam, serta mengeksplorasi makna dan tujuan hidup (Yoost & Crawford, 2016; Ramadani dkk., 2021). Kebutuhan spiritual mencakup tiga aspek utama, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), serta hubungan dengan orang lain (interpersonal). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasojo (2017), spiritualitas berperan dalam membantu individu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih menghargai kehidupan setelah menerima diagnosis HIV/AIDS, serta membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Selain itu, spiritualitas juga menumbuhkan harapan akan kehidupan yang lebih baik

di masa depan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto et al. (2018) menyoroti pentingnya dukungan keluarga dalam aspek emosional dan spiritual. Dukungan tersebut mencakup cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta membangun harapan yang lebih positif terhadap kehidupan yang dijalani.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasajo (2017), individu yang didiagnosis HIV/AIDS menemukan makna baru dalam kehidupan spiritual mereka, di mana mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan setelah menerima diagnosis tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armiyati et al. (2015), yang menunjukkan bahwa ODHA cenderung semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setelah mengetahui status kesehatannya. Pendekatan spiritual dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berdoa, membaca kitab suci, merenungkan berbagai berkah dalam kehidupan, serta menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cara-cara ini diyakini mampu meningkatkan spiritualitas seseorang (Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Dalmida et al. (2015) juga menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang diteliti secara aktif terlibat dalam layanan keagamaan secara rutin serta menjalankan doa sebagai bagian dari kehidupan mereka. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arrey, Bilsen, Lacor, & Deschepper (2016), yang mengungkapkan bahwa kegiatan seperti berdoa, meditasi, mengikuti kebaktian secara teratur, serta terlibat dalam aktivitas keagamaan merupakan sumber utama spiritualitas bagi ODHA dalam memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Praktik spiritual yang dijalankan oleh pasien HIV/AIDS menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Beberapa bentuk pemenuhan kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan oleh ODHA meliputi berbagai aktivitas religius yang memperkuat ketenangan batin dan memberikan makna dalam kehidupan mereka. Praktik kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

1. Berdoa

Berdoa merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan kapan saja, baik secara mandiri maupun dipimpin oleh pemuka agama, sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Secara umum, doa dipahami sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan hal-hal baik, seperti pengampunan, kasih sayang, dan kesembuhan (O'Brien, 2011). Menurut penelitian Dalmida et al. (2015), mayoritas pasien HIV/AIDS rutin berdoa setiap hari atau lebih sering, dengan persentase mencapai 66,2%. Hal ini sejalan dengan temuan Arrey, Bilsen, Lacor, & Deschepper (2016), yang menyatakan bahwa doa merupakan salah satu sumber utama spiritualitas yang membantu individu merasa lebih terhubung dengan Tuhan.

Selain itu, penelitian mengenai pengalaman spiritual pasien HIV/AIDS menunjukkan bahwa penderitaan yang mereka alami memberikan nilai serta makna baru dalam hidup. Makna baru tersebut diwujudkan melalui berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti berdoa, berdzikir, serta melakukan aktivitas keagamaan seperti membaca ayat-ayat kitab suci (Sugiyanto et al., 2018). Hasil penelitian Amal & Khofsoh (2017) juga mengungkapkan bahwa kebutuhan spiritual dalam dimensi religius yang paling penting bagi pasien adalah berdoa, baik secara pribadi maupun melalui doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk mereka. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa diyakini dapat membawa ketenangan jiwa. Lebih lanjut, penelitian Dalmida et al. (2015) menunjukkan bahwa individu yang jarang berdoa dalam kesehariannya cenderung memiliki kualitas hidup mental (HRQoL) yang lebih rendah serta kesejahteraan emosional yang lebih buruk dibandingkan mereka yang lebih sering berdoa.

2. Meditasi

Meditasi adalah aktivitas yang berfokus pada pemusatan pikiran atau refleksi diri untuk menemukan makna dalam suatu hal. Beberapa individu percaya bahwa meditasi yang mendalam dapat membantu mengendalikan serta memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perkembangan suatu penyakit (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Arrey, Bilsen, Lacor, & Deschepper (2016) menunjukkan bahwa meditasi berperan sebagai salah satu sumber spiritual atau religius yang membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan Tuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Szaflarski (2013), yang menyatakan bahwa intervensi spiritual, seperti meditasi, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Pada pasien HIV/AIDS, meditasi terbukti mampu mengurangi stres serta kecemasan, sehingga dapat meningkatkan respons emosional yang lebih positif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sutioningsih, Suniawati, & Suhuda (2019) mengungkapkan bahwa terapi meditasi, seperti dzikir, memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat stres pada pasien.

3. Dukungan dari orang terdekat

Dalam kondisi penuh tekanan, seseorang cenderung mencari kekuatan melalui keyakinan agamanya. Dukungan spiritual memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan kesehatan, terutama bagi individu dengan penyakit yang memerlukan proses pemulihan jangka panjang (Mubarak et al., 2015). Dukungan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, dapat menjadi sumber motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan dengan HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh Prasajo (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang terlibat dalam penelitian ini mendapatkan dukungan dari keluarga, seperti pasangan dan orang tua. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Safitri (2020), yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden

memiliki dukungan keluarga yang kuat. Selain itu, penelitian oleh Novrianda, Nurdin, & Ananda (2015) juga menunjukkan bahwa sebagian besar individu dengan HIV/AIDS menerima dukungan positif dari keluarga mereka.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Sugiyanto et al. (2018) menegaskan bahwa dukungan dan interaksi sosial paling banyak diberikan oleh keluarga, termasuk pasangan, saudara, orang tua, dan anak. Bentuk dukungan tersebut meliputi dukungan emosional serta spiritual. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk penghargaan, bantuan materi, informasi, serta dorongan untuk bersosialisasi. Dukungan keluarga yang komprehensif ini dapat membantu proses pemulihan secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Rahakbauw, 2016).

D. Asuhan Keperawatan Komunitas Pada Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang sudah terlewati memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga untuk kehidupan manusia. Masyarakat dan setiap elemen bangsa secara bersama-sama bergotong royong dalam upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19, karena COVID-19 juga teridentifikasi pada tingkat cluster yang paling kecil, yakni keluarga. Penularan pada *cluster* keluarga perlu mendapat perhatian, karena apabila salah satu anggota keluarga terkonfirmasi, maka kemungkinan besar anggota keluarga yang lainnya juga akan beresiko terkonfirmasi COVID-19. Hal ini tentunya memerlukan peran perawat komunitas sebagai garda terdepan petugas kesehatan yang ada di komunitas.

Harapan merupakan konsep yang erat kaitannya dengan spiritualitas. Spiritualitas sendiri adalah proses yang melibatkan interaksi antara pemikiran, tindakan, serta hubungan dengan orang lain, yang diarahkan pada pencapaian tujuan bermakna di masa depan (Berman et al., 2015). Bagi individu dengan HIV/AIDS, harapan dapat memberikan dorongan untuk tetap berjuang dan menjaga kesehatannya agar kondisinya tidak memburuk. Dalam penelitian Prasojo (2017),

partisipan mengungkapkan harapan untuk tetap dapat bekerja seperti biasa, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, serta berharap agar masyarakat lebih menerima ODHA tanpa stigma dan diskriminasi. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah terus memberikan pelayanan yang mempermudah akses obat-obatan secara gratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Dewi, & Erwin (2015) mengungkapkan bahwa harapan ODHA mencakup berbagai aspek, baik dari diri sendiri—seperti ingin sehat dan menemukan obat yang dapat menyembuhkan—maupun dari lingkungan, yakni diterima tanpa mengalami pengucilan. Harapan dan impian menjadi tujuan yang mendorong ODHA untuk bertahan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, penelitian Sugiyanto et al. (2018) menyebutkan bahwa selain berharap untuk sembuh, partisipan juga ingin menjalani kehidupan yang normal, kembali bekerja, serta berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Dalam mewujudkan harapannya, banyak individu berusaha dengan berbagai cara, seperti berdoa dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

E. Persepsi Positif Penderita HIV

Berbagai hasil penelitian mengenai persepsi penderita HIV positif terhadap penyakit HIV dan AIDS menunjukkan bahwa mayoritas informan menganggap HIV dan AIDS sebagai penyakit yang mematikan dan tidak dapat disembuhkan, dengan ketergantungan seumur hidup pada terapi ARV. Pandangan ini juga diperkuat oleh informasi dari triangulasi, yang menunjukkan bahwa penderita HIV positif memahami bahwa HIV adalah penyakit yang tidak memiliki obat penyembuh dan berisiko fatal. Kesadaran akan sifat mematikan penyakit ini menjadi sumber ketakutan dan kecemasan bagi para penderita. Dalam upaya memperoleh pengobatan, mereka umumnya mengakses layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa sebagian besar

penderita HIV dan AIDS memiliki sikap positif terhadap kondisi mereka. Mereka menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai HIV, termasuk aspek penularan, pencegahan, serta metode pengobatan yang tersedia (Rokhmahdan Khoiron, 2013).

Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa meskipun telah mengetahui upaya pencegahan penularan, karena keinginan untuk memiliki anak upaya pencegahan penularan tersebut tidak dilakukannya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, mayoritas informan dalam penelitian ini telah memiliki tingkat pemahaman yang cukup mengenai HIV, termasuk langkah-langkah pencegahan dan pengobatannya. Namun, terdapat beberapa informan yang tetap mengabaikan risiko yang dihadapi, terutama karena keinginan untuk memiliki anak. Penelitian lain yang dilakukan di Ebonyi, Nigeria, juga menunjukkan bahwa HIV dipersepsikan sebagai penyakit menular yang berisiko menyebabkan kematian. Tingkat pengetahuan mengenai virus HIV serta informasi terkait tergolong tinggi, dengan sumber utama informasi berasal dari kementerian kesehatan setempat (Dr. J.O.E. Egbo dan Chukwu, V. A, 2015).

Persepsi terhadap HIV sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian lain di Nigeria menyoroti pentingnya studi mengenai persepsi dan pemahaman mahasiswa terhadap HIV sebagai bagian dari upaya pencegahan. Studi tersebut juga mengungkap bahwa terdapat mahasiswa yang terlibat dalam perilaku seksual berisiko, sehingga hasil penelitian merekomendasikan integrasi pendidikan seksual ke dalam kurikulum nasional Nigeria (Awole A. O., et al., 2011). Selain itu, ketersediaan ARV menjadi kendala yang dirasakan oleh informan dalam pengobatan HIV. Informan juga menyadari bahwa tanpa pengobatan segera, HIV dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh serta diare berkepanjangan. Risiko utama yang dipahami oleh informan terkait HIV adalah kemungkinan kematian serta ketergantungan terhadap obat sepanjang hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa beberapa informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, termasuk yang pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial. Selain itu, salah satu informan berstatus sebagai ibu rumah tangga dengan suami yang terdiagnosis HIV positif dan bekerja sebagai sopir. Informan tersebut mengungkapkan bahwa selama menjalani profesinya sebagai sopir, suaminya kerap mengunjungi tempat-tempat hiburan untuk bersantai serta berinteraksi dengan pekerja seks komersial.

Perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal pada penderita HIV positif menyebabkan mereka mengembangkan persepsi negatif terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan konsep dirinya. Penderita HIV positif cenderung menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang adaptif, yang dipicu oleh ketidakmampuan mereka dalam menerima kondisi yang dihadapi. Situasi ini semakin diperparah oleh anggapan bahwa HIV merupakan penyakit yang belum memiliki obat untuk menyembuhkannya. Berbagai masalah yang dialami penderita HIV positif, baik secara fisik maupun psikologis, meliputi stres, penurunan berat badan, kecemasan, gangguan kulit, frustrasi, kebingungan, gangguan daya ingat, menurunnya semangat kerja, rasa takut, perasaan bersalah, penolakan sosial, depresi, bahkan kecenderungan untuk mengakhiri hidup (Wahyu, 2012). Hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa HIV positif menimbulkan keresahan yang signifikan bagi penderitanya, dengan kematian menjadi ketakutan terbesar dalam menjalani kehidupan. Selain itu, kondisi kesehatan yang rentan terhadap infeksi turut berdampak pada aspek ekonomi mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa penderita HIV cenderung mengalami depresi, yang sebagian besar disebabkan oleh keyakinan bahwa HIV menandai akhir dari kehidupan mereka (L.S. Eller, 2013).

F. Strategi Koping Penderita HIV

Salah satu strategi koping yang diterapkan oleh penderita HIV adalah menjalankan ibadah salat, yang dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat keyakinan dalam menghadapi penyakit. Selain itu, mereka juga secara aktif mencari informasi terkait pengobatan HIV. Meskipun sebagian besar memiliki persepsi bahwa HIV adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak memiliki obat, dan berujung pada kematian, keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan serta sikap positif yang mereka kembangkan membantu mereka menerima HIV sebagai bagian dari takdir yang berada dalam kendali-Nya. Proses koping ini tidak terjadi secara instan setelah mereka menerima diagnosis HIV, melainkan berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Nigeria, yang menunjukkan bahwa dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penderita HIV (Oluyemisi Folake Folasire, et al, 2014).

Beberapa penderita AIDS memilih untuk tidak bekerja karena takut kondisi kesehatannya diketahui oleh orang lain. Mereka cenderung menarik diri dan mengisolasi diri sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kerahasiaan penyakitnya serta untuk menghindari rasa malu di hadapan masyarakat. Selain itu, strategi koping ini juga disertai dengan upaya mencari dukungan sosial (seeking social support) dengan mengandalkan orang-orang terdekat untuk memperoleh kenyamanan, motivasi, dan dorongan emosional.

Salah satu cara yang mereka lakukan untuk mengurangi tekanan akibat HIV adalah dengan berbagi perasaan kepada orang terdekat, termasuk menceritakan kondisi kesehatan serta berbagai tekanan yang mereka alami. Temuan dari wawancara mendalam dalam penelitian ini diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa pemilihan strategi koping yang tepat dapat membantu penderita HIV dalam mengurangi tekanan psikologis dan tingkat depresi akibat penyakit tersebut (Wayne A. Bardwell PhD, et al., 2001). Salah satu strategi koping

yang terbukti efektif dalam meredakan tekanan adalah mendapatkan dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat.

Dukungan sosial memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas strategi koping yang diterapkan oleh penderita HIV positif. Temuan ini selaras dengan berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara dukungan sosial dan tingkat depresi pada penderita HIV. Gangguan mental pada individu umumnya dipicu oleh berbagai faktor psikososial yang berkaitan dengan pengalaman kehilangan. Faktor-faktor tersebut mencakup berkurangnya peran sosial, hilangnya kemandirian, kehilangan teman atau anggota keluarga, penurunan kondisi kesehatan, meningkatnya isolasi sosial, keterbatasan ekonomi, serta penurunan fungsi kognitif (Yaunin, 2014).

Peranan suami atau istri bagi informan diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan akibat HIV yang dideritanya. Upaya lainnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan serta mencari kesibukan bahkan merokok juga diambil informan sebagai upaya yang dapat membuat informan merasa lebih rileks dari tekanan HIV. Upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh informan dalam wawancara mendalam sejalan dengan temuan penelitian lain, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penderita HIV menerapkan strategi koping dengan meningkatkan kualitas spiritual mereka. Hal ini dilakukan melalui penguatan keimanan serta mencari dukungan sosial dari lembaga layanan mental dan keagamaan. Dengan demikian, tekanan psikologis akibat HIV dapat dikelola dengan lebih efektif oleh para penderita (Somlai & Heckman, 2000).

Setelah mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV, sebagian besar penderita HIV/AIDS rutin mengunjungi konselor HIV dengan frekuensi sekitar sekali dalam sebulan. Tujuan kunjungan mereka beragam, mulai dari mencari informasi lebih mendalam mengenai HIV hingga menemukan tempat yang aman dan nyaman

untuk mengekspresikan perasaan mereka. Strategi koping yang diterapkan oleh penderita HIV positif termasuk dalam kategori problem-focused coping dengan pendekatan seeking social support. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis dengan mencari rasa aman dan nyaman melalui dukungan sosial, motivasi, kesempatan untuk mencurahkan isi hati, serta perasaan dihargai dan diperhatikan oleh orang lain.

Individu yang mengalami tekanan akibat permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan seperti HIV, sangat membutuhkan dukungan sosial. Bagi penderita HIV positif, konselor HIV diharapkan dapat berperan sebagai teman dan pendamping yang memberikan dukungan emosional, perhatian, serta bantuan dalam mengurangi beban dan tekanan akibat penyakit tersebut. Stigma yang masih melekat di masyarakat terhadap penderita HIV positif berdampak signifikan pada kondisi psikologis mereka. Akibatnya, banyak penderita merasa malu, menarik diri, serta cenderung mengisolasi diri dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi koping avoidance, seperti isolasi sosial, dapat memperburuk kesehatan mental penderita HIV (McIntosh, 2012).

Bagi penderita HIV positif, keberadaan konselor dipandang sebagai kebutuhan psikologis yang berperan dalam strategi koping seeking social support. Seluruh informan dalam penelitian ini menilai bahwa kehadiran konselor sangat membantu mereka dalam mengurangi tekanan psikologis serta berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, meskipun mereka hidup dengan HIV. Konseling telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan dan depresi pada penderita HIV. Selain itu, konseling juga berperan dalam mempercepat pemulihan dari trauma serta menjadi sarana untuk memperbaiki komunikasi antara penderita HIV dengan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, konseling diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Gupta, 2010).

G. Penutup

Penurunan kondisi kesehatan fisik menjadi stressor utama bagi penderita HIV positif, yang kemudian diperparah oleh stigma sosial di masyarakat. Kondisi ini mendorong mereka untuk menerapkan berbagai strategi koping guna menghadapi tekanan yang dialami. Salah satu strategi koping yang digunakan adalah problem-focused coping, yang mencakup confrontative coping, seeking social support, serta planful problem-solving. Sehingga untuk mendukung peningkatan kualitas hidup penderita HIV positif, pemerintah setempat dan Komisi Penanggulangan AIDS bekerja sama dengan LSM penggiat HIV membantuk jejaring yang lebih kuat dalam rangka menciptakan peningkatan layanan VCT, ARV maupun konseling. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal ketrampilan dan program pendampingan bagi penderita HIV sehingga dapat meningkatkan dan menyelesaikan persoalan ekonomi penderita HIV positif. Untuk mencegah penyebaran HIV serta meningkatkan dukungan sosial bagi penderita HIV positif, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, HIV, AIDS, dan pendidikan seksual di kalangan masyarakat. Selain itu, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, HIV, dan AIDS sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda dapat memahami serta menyadari risiko dan pencegahan HIV sejak dini, sehingga angka kasus HIV dan AIDS dapat dikurangi.

Referensi

- Amiya, R. M., Poudel, K. C., Poudel-Tandukar, K., Pandey, B. D., & Jimba, M. (2014). Perceived Family Support, Depression, and Suicidal Ideation among People Living with HIV/AIDS: A Cross-Sectional Study in the Kathmandu Valley, Nepal. *PLoS ONE*, 9(3), e90959. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090959>
- Brunner & Suddarth. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Edisi 12 volume 1*. Jakarta. EGC.
- Djumadi, J., & Gobel, F. A. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Terapi Antiretroviral (ARV) pada Pengidap HIV/AIDS di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar Tahun 2022. *Vol.*, 4(1), 78–90. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1193>
- Nisak, A. A. (2024). *Dukungan Sosial dengan Kebermaknaan Hidup pada Pasien ODHA*. 6(1).
- Nisak, A. A. & Liyanovitasari. (2024). Dukungan Sosial dengan Kebermaknaan Hidup pada Pasien ODHA: Social Support with Meaning of Life in PLHIV patients. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 6(1), 10–20. <https://doi.org/10.35473/jhhs.v6i1.359>
- Nomiko, D., Yellyanda, Y., Eliezer, B., & Maryastuty, A. (2021). Kontribusi Dukungan Keluarga dan Sikap dalam Penguatan Mekanisme Koping Pasien HIV/AIDS di Poli VCT RSUD Raden Mattaher Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 958. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1653>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Salemba Medika.
- Pooroe, I. G., Yuniwati, E. S., & Wungubelen, B. L. (2023). Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Menderita HIV/AIDS Di Kota Malang. *PSIKOVIDYA*, 26(2), 61–70. <https://doi.org/10.37303/psikovidya.v26i2.210>
- Prasetya, G., Nur Sartika, A., Noerfitri, N., Mirnawati, D., Gultom, E. Y., & Sari, M. F. (2024). EDUKASI GIZI SEIMBANG CEGAH ANEMIA PADA REMAJA SEKOLAH DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. *Jurnal Mitra Masyarakat (JMM)*, 5(1), 24–32. <https://doi.org/10.47522/jmm.v5i1.185>
- Prasojo, D. (2017). Peran Reliugisitas pada Penderita HIV dan AIDS yang mengalami Depresi. *Jurnal Studia Insania*, 5(1), 46. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1270>
- Priharwanti, A., & Raharjo, B. B. (2017). Problems Focused Coping Penderita HIV Positif. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 131–139.
- Ramadani, S. P., Hastuti, M. F., & Yulanda, N. A. (2021). KEBUTUHAN SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS: LITERATURE REVIEW. *Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak*, 1(1).

- Salami, S., Muvira, A. A., & Yualita, P. (2021). Studi Kualitatif Strategi Koping Penderita HIV AIDS di Kota Bandung. *Faletehan Health Journal*, 8(01), 22–30. <https://doi.org/10.33746/fhj.v8i01.243>
- Siyoto, S., Peristiowati, Y., & Agustin, E. (2016). Mekanisme Koping pada Odha dengan Pendekatan Teori Adaptasi Callista Roy. *Jurnal Ners*, 11(2), 256–260. <https://doi.org/10.20473/jn.v11i2.2274>
- Smet, B. (2014). *Psikologi Kesehatan*. Gramedia Widiasaruna Indonesia.
- Wardoyo, E. H., Budyono, C., & Asmara, I. G. Y. (2018). Peran Dukungan Keluarga Pasien HIV yang Menjalani Terapi Anti Retroviral di Klinik VCT RSUD Provinsi NTB terhadap Outcome Klinis. *Unram Medical Journal*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.29303/jku.v7i1.162>

BAB III

PERAN KOMUNITAS DALAM MENDUKUNG PASIEN HIV/AIDS

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum Epidemi HIV/AIDS di Indonesia dan Global

HIV/AIDS tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan baik di tingkat global maupun nasional.^{Vox+1}^{Verywell Health+1}

Secara global, pada akhir tahun 2023, diperkirakan terdapat 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta orang merupakan infeksi baru, dan 630.000 orang meninggal akibat penyakit terkait AIDS .^{Universitas Esa Unggul+10}^{HIV.gov+10}^{World Health Organization+10}^{Verywell Health+3}^{United Nations+3}^{UNAIDS+3}

Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga Maret 2023, kasus HIV telah dilaporkan oleh 34 provinsi. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan terus meningkat, dengan kelompok ibu rumah tangga menjadi salah satu yang paling terdampak, mencapai 35% dari total kasus .^{hivaidspimsindonesia.or.id+1}^{E-Journal Um Sorong+1}^{Sehat Negeriku}

Meskipun terdapat penurunan tingkat insidensi HIV dari 21 per 100.000 penduduk pada tahun 2011 menjadi 10 per 100.000 pada tahun 2021, angka kematian terkait AIDS meningkat dari 3,4% pada 2010 menjadi 4,8% pada 2020 .^{BioMed Central}

2. Pentingnya Peran Komunitas dalam Mendukung Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Peran komunitas dalam mendukung ODHA sangat krusial dalam upaya pencegahan, perawatan, dan pengendalian HIV/AIDS. Komunitas dapat berperan dalam memberikan edukasi, mendukung kepatuhan terhadap pengobatan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh ODHA.

Studi di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan sosial dari komunitas berhubungan positif dengan peningkatan harga diri dan kualitas hidup ODHA . Selain itu, keterlibatan komunitas dalam program-program seperti konseling sebaya dan pendampingan pengobatan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap terapi antiretroviral .Frontiers On Healthcare

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat akses ODHA terhadap layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman stigma di fasilitas kesehatan dapat mempengaruhi keputusan ODHA untuk mencari perawatan . Oleh karena itu, peran komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan bebas stigma sangat penting untuk keberhasilan program HIV/AIDS.

B. Peran Komunitas dalam Deteksi Dini dan Pencegahan HIV/AIDS

1. Inisiatif Komunitas dalam Edukasi dan Promosi Kesehatan

Peran komunitas dalam edukasi dan promosi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS. Program edukasi berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kampanye perubahan perilaku dan mobilisasi komunitas. YCCP mengimplementasikan komunikasi perubahan perilaku dan kegiatan mobilisasi komunitas untuk memberdayakan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, termasuk HIV/AIDS. Wikipedia

Selain itu, program GenRe (Generasi Berencana) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melibatkan duta GenRe sebagai pendidik sebaya untuk menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS kepada remaja. Studi menunjukkan bahwa duta GenRe berperan penting dalam meningkatkan perilaku pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja. PMC

2. Program Skrining dan Testing Berbasis Komunitas

Program skrining dan testing berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi dini HIV, terutama di kalangan populasi kunci seperti pekerja seks perempuan (PSP) dan pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM). Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjangkau individu yang tidak terlayani oleh layanan kesehatan formal.

Di Indonesia, program tes HIV mandiri berbasis komunitas telah diimplementasikan di 23 kabupaten prioritas untuk PSP. Program ini memungkinkan PSP untuk melakukan tes HIV secara mandiri di lingkungan yang aman dan nyaman, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam melakukan tes. CenterWatch

3. Studi Kasus: Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan HIV/AIDS di Indonesia

Salah satu contoh keberhasilan peran komunitas dalam pencegahan HIV/AIDS di Indonesia adalah program yang dilaksanakan oleh International AIDS Conference (IAC) dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Program ini melibatkan komunitas dalam penyediaan layanan pencegahan HIV yang dipimpin oleh sebaya, khususnya untuk PSP, serta integrasi skrining kekerasan berbasis gender dalam program outreach. Pendekatan berbasis hak asasi manusia ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk respons HIV yang sukses. UNAIDS

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO), telah mengimplementasikan program pencegahan HIV di tempat kerja. Program ini bertujuan untuk mencapai tiga nol: nol infeksi HIV baru, nol kematian terkait AIDS, dan nol diskriminasi. Integrasi program edukasi HIV di tempat kerja ke dalam program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memainkan peran penting dalam mendorong layanan inklusif dan kebijakan non-diskriminatif perusahaan.

C. Dukungan Psikososial dan Penguatan Mental ODHA

1. Peran Kelompok Dukungan Sebaya dalam Meningkatkan Kualitas Hidup ODHA

Kelompok dukungan sebaya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Melalui interaksi dengan sesama ODHA, individu dapat berbagi pengalaman, memperoleh informasi, dan mendapatkan dukungan emosional yang dapat mengurangi perasaan isolasi dan stigma. Studi menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan sebaya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kepatuhan terhadap pengobatan.

2. Dampak Dukungan Komunitas terhadap Kesehatan Mental dan Kepatuhan Pengobatan

Dukungan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kepatuhan pengobatan ODHA. Program dukungan berbasis komunitas yang dipimpin oleh sebaya telah terbukti meningkatkan hasil pengobatan HIV dan kelangsungan hidup ODHA. Studi di Wuxi, China, menunjukkan bahwa ODHA yang menerima dukungan komunitas memiliki tingkat kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ART) yang lebih tinggi, retensi dalam perawatan yang lebih baik, dan tingkat supresi viral yang lebih tinggi

dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima perawatan klinis rutin.
PMC

Selain itu, dukungan komunitas dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi ODHA, serta menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan sosial yang diperlukan. Intervensi berbasis komunitas yang melibatkan pekerja kesehatan masyarakat dan organisasi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil pengobatan dan kesejahteraan ODHA.

3. Praktik Baik: Program Dukungan Komunitas di Uganda dan Hasilnya

Uganda telah mengimplementasikan berbagai program dukungan komunitas yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ODHA. Salah satu contoh adalah program terapi kelompok yang dipimpin oleh pekerja kesehatan non-profesional di Uganda Utara, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala depresi dan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan di antara ODHA yang berpartisipasi. Wikipedia

Selain itu, Bwindi Community Hospital di Uganda menjalankan program dukungan komunitas yang mencakup pengujian dan pengobatan HIV di daerah terpencil, serta kelompok dukungan pasien yang bertemu secara rutin untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Program ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma terkait.

D. Dukungan Psikososial dan Penguatan Mental ODHA

1. Peran Kelompok Dukungan Sebaya dalam Meningkatkan Kualitas Hidup ODHA

Kelompok dukungan sebaya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Melalui interaksi dengan sesama ODHA, individu dapat berbagi pengalaman, memperoleh informasi, dan mendapatkan dukungan emosional yang dapat mengurangi perasaan isolasi dan stigma. Studi menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan sebaya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kepatuhan terhadap pengobatan.

2. Dampak Dukungan Komunitas terhadap Kesehatan Mental dan Kepatuhan Pengobatan

Dukungan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kepatuhan pengobatan ODHA. Program dukungan berbasis komunitas yang dipimpin oleh sebaya telah terbukti meningkatkan hasil pengobatan HIV dan kelangsungan hidup ODHA. Studi di Wuxi, China, menunjukkan bahwa ODHA yang menerima dukungan komunitas memiliki tingkat kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ART) yang lebih tinggi, retensi dalam perawatan yang lebih baik, dan tingkat supresi viral yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima perawatan klinis rutin.

Selain itu, dukungan komunitas dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi ODHA, serta menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan sosial yang diperlukan. Intervensi berbasis komunitas yang melibatkan pekerja kesehatan masyarakat dan organisasi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil pengobatan dan kesejahteraan ODHA.

3. Praktik Baik: Program Dukungan Komunitas di Uganda dan Hasilnya

Uganda telah mengimplementasikan berbagai program dukungan komunitas yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ODHA. Salah satu contoh

adalah program terapi kelompok yang dipimpin oleh pekerja kesehatan non-profesional di Uganda Utara, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala depresi dan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan di antara ODHA yang berpartisipasi.

Selain itu, Bwindi Community Hospital di Uganda menjalankan program dukungan komunitas yang mencakup pengujian dan pengobatan HIV di daerah terpencil, serta kelompok dukungan pasien yang bertemu secara rutin untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Program ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma terkait.

E. Pendampingan Terapi dan Kepatuhan Pengobatan

1. Peran Pendamping Sebaya dalam Meningkatkan Kepatuhan terhadap Terapi Antiretroviral (ARV)

Pendamping sebaya, yaitu individu yang juga hidup dengan HIV, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ARV) di kalangan ODHA. Melalui pendekatan berbasis pengalaman pribadi, pendamping sebaya dapat memberikan dukungan emosional, informasi yang relevan, dan motivasi kepada sesama ODHA. Studi menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan pendamping sebaya efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ARV dan retensi dalam perawatan.

2. Implementasi Program "Bulan Viral Load" dan Keterlibatan LSM

Program "Bulan Viral Load" merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan viral load di kalangan ODHA. Di Indonesia, program ini telah diimplementasikan dengan dukungan dari berbagai LSM dan organisasi berbasis komunitas. Melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti pengumpulan sampel mobile dan jam layanan yang diperpanjang, program ini

berhasil meningkatkan akses ODHA terhadap pemeriksaan viral load. Sebagai contoh, dari November 2022 hingga September 2023, sebanyak 262 klien, termasuk 80 klien di penjara, telah mendapatkan layanan pengumpulan sampel viral load melalui layanan mobile. FHI 360

3. Model Komunitas sebagai Jembatan antara Pasien dan Layanan Kesehatan

Model komunitas berperan sebagai jembatan yang efektif antara ODHA dan layanan kesehatan formal. Melalui keterlibatan pekerja kesehatan masyarakat (community health workers) dan organisasi berbasis komunitas, model ini membantu mengatasi hambatan dalam akses layanan kesehatan, seperti stigma, diskriminasi, dan keterbatasan sumber daya. Integrasi pekerja kesehatan masyarakat ke dalam klinik HIV telah terbukti meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan dan meningkatkan hasil pengobatan.

F. Penanggulangan Stigma dan Diskriminasi

1. Upaya Komunitas dalam Mengurangi Stigma terhadap ODHA

Stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) merupakan hambatan signifikan dalam upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Komunitas memainkan peran penting dalam mengurangi stigma ini melalui berbagai inisiatif.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah program berbasis komunitas yang melibatkan ODHA sebagai pendamping sebaya. Program ini memungkinkan ODHA untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan emosional kepada sesama, yang dapat mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan penerimaan diri. Studi menunjukkan bahwa dukungan sebaya dapat

meningkatkan keterlibatan ODHA dalam perawatan dan pengobatan, serta mengurangi stigma internal yang mereka rasakan.

Selain itu, kampanye edukasi yang melibatkan komunitas lokal telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma. Misalnya, program yang dilaksanakan oleh Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) di Indonesia menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku dan mobilisasi komunitas untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, termasuk stigma terhadap ODHA.

2. Peran Komunitas dalam Memfasilitasi Disclosure Status HIV kepada Pasangan

Disclosure status HIV kepada pasangan merupakan langkah penting dalam pencegahan penularan HIV. Namun, banyak ODHA yang enggan mengungkapkan status mereka karena takut akan stigma dan diskriminasi. Komunitas dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses disclosure ini.

Studi di Medan, Indonesia, menunjukkan bahwa dukungan sebaya memiliki korelasi signifikan dengan keterbukaan ODHA dalam mengungkapkan status HIV mereka kepada pasangan. ODHA yang menerima dukungan dari kelompok sebaya lebih cenderung untuk melakukan disclosure dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima dukungan tersebut.

Selain itu, program notifikasi pasangan yang dibantu (assisted partner notification) telah diimplementasikan di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, dan Denpasar. Program ini melibatkan penyedia layanan kesehatan dan komunitas dalam membantu ODHA memberitahukan status HIV mereka kepada pasangan dengan cara yang aman dan mendukung. Hasilnya

menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akses pasangan ODHA terhadap tes dan pengobatan HIV. PMC+1BioMed Central+1

3. Kampanye dan Edukasi Masyarakat untuk Mengubah Persepsi Negatif

Kampanye dan edukasi masyarakat merupakan strategi penting dalam mengubah persepsi negatif terhadap ODHA. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS, mengurangi ketakutan yang tidak berdasar, dan mempromosikan sikap inklusif terhadap ODHA.

Di Indonesia, berbagai kampanye telah dilakukan untuk mengurangi stigma, termasuk pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang HIV/AIDS dan mengurangi diskriminasi terhadap ODHA di fasilitas kesehatan. Studi menunjukkan bahwa intervensi ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ODHA dan mengurangi stigma yang mereka alami.

Selain itu, kampanye publik yang melibatkan media massa dan media sosial telah digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang HIV/AIDS dan menantang stereotip negatif. Misalnya, program "Positive Heroes" di Afrika Selatan menggunakan cerita inspiratif dari ODHA untuk mengubah persepsi masyarakat dan mengurangi stigma.

G. Keterlibatan Komunitas dalam Kebijakan dan Advokasi

1. Partisipasi Komunitas dalam Perumusan Kebijakan HIV/AIDS

Keterlibatan komunitas dalam perumusan kebijakan HIV/AIDS sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Pendekatan ini dikenal sebagai Meaningful Involvement of People with HIV/AIDS (MIPA), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif ODHA dalam semua aspek pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. MIPA mendorong keterlibatan ODHA dalam penelitian, pengembangan kebijakan, dan implementasi program, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan efektif .jces.ua.edu

Di Indonesia, prinsip MIPA telah diadopsi dalam berbagai program penanggulangan HIV/AIDS, dengan melibatkan ODHA dalam forum-forum konsultasi dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara dan pengalaman ODHA menjadi bagian integral dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan, pengobatan, dan dukungan bagi ODHA.

2. Studi Kasus: Keterlibatan Komunitas dalam Program Ryan White HIV/AIDS di Amerika Serikat

Program Ryan White HIV/AIDS di Amerika Serikat merupakan contoh sukses keterlibatan komunitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan HIV/AIDS. Program ini menyediakan layanan medis dan dukungan bagi individu berpenghasilan rendah yang hidup dengan HIV/AIDS. Salah satu aspek kunci dari program ini adalah pembentukan Planning Councils yang terdiri dari ODHA, penyedia layanan, dan anggota komunitas lainnya. Dewan ini bertanggung jawab untuk menentukan prioritas layanan dan alokasi dana, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan komunitas .

Keterlibatan komunitas dalam program ini telah meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil dan efisien. Model ini menunjukkan bahwa partisipasi

aktif komunitas dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

3. Peran Organisasi Berbasis Komunitas dalam Advokasi Hak ODHA

Organisasi berbasis komunitas (OBK) memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak ODHA. OBK sering kali berada di garis depan dalam memperjuangkan akses terhadap layanan kesehatan, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Misalnya, di Amerika Serikat, organisasi seperti Black AIDS Institute dan San Francisco AIDS Foundation telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan layanan, dan mempengaruhi kebijakan untuk mendukung komunitas yang terdampak HIV/AIDS .Healthline

Di Indonesia, OBK seperti Yayasan Spiritia dan Jaringan Indonesia Positif (JIP) telah aktif dalam memberikan dukungan kepada ODHA, melakukan edukasi masyarakat, dan terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Keterlibatan OBK ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dikembangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas yang terdampak.

H. Studi Kasus dan Praktik Baik

1. Program LoveYourself di Filipina sebagai Model Dukungan Komunitas

LoveYourself Inc. merupakan organisasi berbasis komunitas di Filipina yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, khususnya di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM) dan komunitas transgender. Didirikan pada tahun 2011, LoveYourself telah berkembang menjadi jaringan dengan lebih dari 1.500 relawan dan mengoperasikan beberapa pusat layanan di Metro Manila dan Cebu. Organisasi ini menyediakan layanan tes HIV gratis, konseling, pengobatan, serta dukungan kesehatan

mental dan trans health. Melalui pendekatan holistik dan berbasis komunitas, LoveYourself berhasil menjangkau lebih dari 100.000 individu untuk skrining HIV/STI dan memberikan pengobatan kepada lebih dari 7.000 klien. LoveYourself Inc.Instagram

Salah satu inisiatif inovatif dari LoveYourself adalah program SelfCare, yang memungkinkan individu untuk melakukan tes HIV secara mandiri di rumah dengan panduan dari asisten virtual. Program ini meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam melakukan tes, serta membantu mengurangi stigma terkait HIV. LoveYourself Inc.+1Tatler Asia+1

2. Inisiatif Humsafar Trust di India dalam Pelayanan HIV/AIDS Berbasis Komunitas

The Humsafar Trust (HST) adalah organisasi berbasis komunitas tertua di India yang didirikan pada tahun 1994, berfokus pada kesehatan dan hak-hak komunitas LGBTQ+. HST telah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang inklusif, termasuk tes HIV, pengobatan, dan dukungan psikososial bagi komunitas MSM dan transgender. Organisasi ini mengoperasikan beberapa klinik di Mumbai, Delhi, Guwahati, dan Nagpur, serta menjalankan program intervensi yang ditargetkan untuk mengurangi prevalensi HIV/STI di kalangan komunitas rentan. Instagram+4HIV Justice Network+4FairPlanet+4Humsafar+1Facebook+1

Pada tahun 2016, HST mendirikan pusat perawatan HIV berbasis komunitas pertama di India yang menyediakan layanan konseling dan terapi antiretroviral (ART) secara gratis. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan bagi komunitas yang sering menghadapi stigma dan diskriminasi dalam sistem kesehatan formal.

3. Peran Bwindi Community Hospital di Uganda dalam Pelayanan HIV/AIDS Terpadu

Bwindi Community Hospital (BCH) di Uganda merupakan contoh praktik baik dalam penyediaan layanan HIV/AIDS terpadu berbasis komunitas. BCH melayani populasi di daerah terpencil dengan menyediakan layanan pencegahan, pengobatan, dan dukungan bagi individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Salah satu inisiatif unggulan BCH adalah Moonlight Clinic, program layanan kesehatan yang beroperasi pada malam hari untuk menjangkau populasi kunci seperti pekerja seks dan komunitas yang sulit dijangkau pada jam operasional biasa. bwindihospital.com

Program ini mencakup tes HIV, konseling, pengobatan, serta edukasi tentang pencegahan HIV. Dengan pendekatan ini, BCH berhasil meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi komunitas yang sebelumnya kurang terlayani, serta membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS di masyarakat.

I. Tantangan dan Rekomendasi

1. Hambatan dalam Pelibatan Komunitas: Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan

Pelibatan komunitas dalam penanggulangan HIV/AIDS menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Organisasi berbasis komunitas (OBK) sering kali kekurangan dana, tenaga kerja terlatih, dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan program secara efektif. Studi menunjukkan bahwa banyak OBK mengalami kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi karena keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Selain itu, pelatihan yang tidak memadai bagi pekerja kesehatan masyarakat dan relawan komunitas menghambat efektivitas program. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan relevan menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan HIV/AIDS yang berkualitas. Hal ini diperparah oleh tingginya tingkat pergantian staf, yang mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam organisasi.

2. Strategi untuk Memperkuat Kapasitas Komunitas dalam Mendukung ODHA

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mendukung Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Menyediakan pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan bagi pekerja kesehatan masyarakat dan relawan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan HIV/AIDS. healthhiv.org
- Pendanaan yang Berkelanjutan: Meningkatkan akses OBK terhadap sumber pendanaan yang berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun donor internasional, untuk memastikan kelangsungan program dan layanan.
- Kemitraan dan Kolaborasi: Mendorong kemitraan antara OBK, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas program.
- Penguatan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi program, serta untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

3. Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi Peran Komunitas dalam Sistem Kesehatan Nasional

Integrasi peran komunitas dalam sistem kesehatan nasional memerlukan dukungan kebijakan yang kuat. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- Pengakuan Resmi terhadap Peran Komunitas: Mengakui secara resmi peran OBK dan komunitas dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung.
- Penyediaan Dana dan Sumber Daya: Menyediakan dana dan sumber daya yang memadai untuk mendukung program komunitas, termasuk pelatihan, infrastruktur, dan logistik.
- Inklusi dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program HIV/AIDS di semua tingkat pemerintahan.
- Penguatan Sistem Rujukan dan Kolaborasi: Membangun sistem rujukan yang efektif antara layanan kesehatan formal dan program komunitas untuk memastikan kontinuitas perawatan bagi ODHA.
- Monitoring dan Evaluasi Berbasis Komunitas: Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan komunitas untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.

Referensi

- Altman, D., Power, R., Lenoir, A., & Daley, E. M. (2014). Enhancing community-based organizations' capacity for HIV/AIDS prevention. *AIDS Education and Prevention*, 26(3), 245–258. <https://doi.org/10.1521/aeap.2014.26.3.245>
- Bwindi Community Hospital. (2025). HIV and TB services. Diakses dari <https://www.bwindihospital.com/hiv.php>
- Bwindi Community Hospital. (2025). Moonlight Clinic: Reaching vulnerable communities at night. Diakses dari <https://www.bwindihospital.com/news.php?page=moonlight>
- FairPlanet. (2019). India's first HIV treatment centre & clinic for LGBTQ. Diakses dari <https://www.fairplanet.org/story/indias-first-hiv-treatment-centre-and-clinic-for-the-lgbtq/>
- FHI 360. (2024). Improving HIV viral load coverage using differentiated service delivery models in Indonesia. Diakses dari <https://www.fhi360.org/wp-content/uploads/2024/11/resource-epic-indonesia-improving-viral-load-success-story.pdf>
- Fitriyani, R. A., & Waluyo, A. (2019). Family acceptance, peer support, and HIV serostatus disclosure of MSM-PLWHA in Medan, Indonesia. *Enfermería Clínica*, 29(3), 189–193. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.070>
- HealthHIV. (2025). Education & Training. Diakses dari <https://healthhiv.org/capacities/education-training/>
- Humsafar Trust. (2025). Health initiatives. Diakses dari <https://humsafar.org/health/>
- International Labour Organization. (2024). Indonesia showcases progresses and achievements on promoting non-discriminatory policies and HIV prevention programmes at workplace. Diakses dari <https://www.ilo.org/resource/news/indonesia-showcases-progresses-and-achievements-promoting-non>
- LoveYourself Inc. (2025). HIV/STI Testing by LoveYourself Inc. Diakses dari <https://loveyourself.ph/hiv-sti-testing/>
- LoveYourself Inc. (2025). LoveYourself: HIV advocacy and support services. Diakses dari <https://loveyourself.ph>

- Ryan White Care Council. (2025). Membership and volunteer information. Diakses dari <https://thecarecouncil.org/membershipvolunteer/>
- Sánchez-Rivero, I., Vázquez-Sánchez, M. Á., & Lillo-Crespo, M. (2021). The peer support on quality of life in people with HIV/AIDS. *Enfermería Clínica*, 31(6), 349–355. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2021.09.002>
- Sari, N. P., Lazuardi, E., Soeharno, N., & Shaluhiyah, Z. (2022). Stigma among healthcare workers in HIV antiretroviral services. *Tropical Medicine & International Health*, 27(1), 1–9. <https://doi.org/10.1111/tmi.14129>
- Sokol, R., Fisher, E., Hill, L., & Schoenbach, V. (2022). Peer support for people living with HIV: A scoping review. *Journal of the International Association of Providers of AIDS Care*, 21, 1–14. <https://doi.org/10.1177/23259582221074474>
- Sprague, C., Simon, S., & Sprague, L. (2021). The meaningful involvement of people with HIV/AIDS (MIPA): A scoping review of best practices. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 14(2), 12–25. Diakses dari <https://jces.ua.edu/articles/26/files/62e180cc0f443.pdf>
- Tran, B. X., Nguyen, L. H., Le, H. T., Latkin, C. A., & Ho, R. C. (2022). Community capacity building for HIV and addiction service integration: A cluster randomized trial in Vietnam. *BMC Public Health*, 22, 1234. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12342-2>
- UNAIDS. (2020). Uganda country report 2020. Diakses dari https://open.unaids.org/sites/default/files/documents/Uganda_Country%20Report_2020_formatted_EN.pdf
- UNAIDS. (2021). Changing the landscape of community engagement in the HIV response in Indonesia. Diakses dari https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/july/20210722_indonesia
- UNAIDS. (2025). Community responses to HIV. Diakses dari <https://www.unaids.org/en/topic/community>
- Wulandari, L. P. L., Ruddick, A., Guy, R., & Kaldor, J. (2021). Perspectives on voluntary assisted partner notification among healthcare providers, people living with HIV and the general population in Indonesia: A formative qualitative study. *BMC Public Health*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10332-8>

Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP). (2025). Community mobilization and behavior change programs. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Cipta_Cara_Padu

Zhang, C., Li, X., & Xu, Y. (2023). Peer-led community-based support services and HIV treatment outcomes: A propensity score–matched retrospective cohort study in Wuxi, China. *JMIR Public Health and Surveillance*, 9, e43635. <https://doi.org/10.2196/43635>

BAB IV

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN PASIEN

A. Pendahuluan

1. Epidemiologi HIV/AIDS Global dan Nasional

a. Global

HIV/AIDS tetap menjadi isu kesehatan masyarakat global yang signifikan. Pada akhir tahun 2023, diperkirakan terdapat 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia. Selama tahun tersebut, sekitar 1,3 juta orang terinfeksi HIV untuk pertama kalinya, dan 630.000 orang meninggal akibat penyakit terkait AIDS. Meskipun angka kematian telah menurun sebesar 69% sejak puncaknya pada tahun 2004, tantangan dalam pencegahan dan pengobatan tetap ada. [Arikesi Journal](#)+1[Wikipedia](#)+1[Wikipedia](#)+3[World Health Organization](#)+3[Arikesi Journal](#)+3[Wikipedia](#)

b. Indonesia

Di Indonesia, epidemi HIV menunjukkan tren peningkatan. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2023, terdapat sekitar 515.455 orang yang hidup dengan HIV. Distribusi kasus berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia 25–49 tahun merupakan yang paling terdampak, dengan persentase 69,8%. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran akan HIV, stigma sosial, dan akses terbatas ke layanan kesehatan berkontribusi pada penyebaran penyakit ini. [Wikipedia](#)+4[Arikesi Journal](#)+4[pitamerah.org](#)+4[pitamerah.org](#)

2. Peran Strategis Keperawatan dalam Manajemen HIV/AIDS

Perawat memegang peran kunci dalam manajemen HIV/AIDS, yang mencakup:

- a. Pemberi Asuhan Keperawatan (Caregiver): Memberikan perawatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial pasien.
- b. Pendidik (Educator): Menyediakan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai HIV/AIDS, pengobatan, dan pencegahan penularan.
- c. Advokat (Advocate): Melindungi hak-hak pasien, termasuk akses ke perawatan yang adil dan bebas dari diskriminasi.Scribd
- d. Konselor (Counselor): Memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien menghadapi diagnosis dan pengobatan .Repository UIN Alauddin Makassar+2Scribd+2UMSurabaya Repository+2

Peran-peran ini menempatkan perawat sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS.

3. Urgensi Pendekatan Multidisiplin dalam Perawatan HIV/AIDS

Pendekatan multidisiplin melibatkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan, termasuk dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial, untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien dengan HIV/AIDS. Pendekatan ini penting karena:gunabangsa.ac.id

- a. Kompleksitas Penyakit: HIV/AIDS mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, sehingga memerlukan intervensi dari berbagai disiplin ilmu.
- b. Peningkatan Kualitas Perawatan: Kolaborasi antarprofesi dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan kepatuhan pasien terhadap terapi .gunabangsa.ac.id
- c. Pengurangan Stigma: Tim multidisiplin dapat bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat dan mengurangi stigma terhadap pasien dengan HIV/AIDS.UNAIDS

Implementasi pendekatan ini telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan pasien dan efisiensi sistem pelayanan kesehatan.

B. Konsep Dasar HIV/AIDS dan Peran Keperawatan

1. Patofisiologi dan Tahapan Infeksi HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus yang menyerang sistem imun, khususnya sel CD4+ T-helper. Setelah infeksi awal, terjadi replikasi virus yang cepat, diikuti oleh penurunan jumlah sel CD4+ dan respons imun yang kuat. Tahapan infeksi HIV meliputi: Wikipedia+1 Merck Manuals+1

- a. Tahap Akut (Infeksi Primer): Terjadi 2–4 minggu setelah paparan, ditandai dengan gejala mirip flu dan viral load tinggi.
- b. Tahap Laten Klinis: Virus tetap aktif tetapi bereplikasi pada tingkat rendah. Pasien mungkin tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun.
- c. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome): Ditandai dengan jumlah sel CD4+ di bawah 200 sel/ μ L dan munculnya infeksi oportunistik atau kanker tertentu.

Pemahaman tentang tahapan ini penting bagi perawat untuk mengidentifikasi tanda-tanda progresi penyakit dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

2. Peran Perawat dalam Diagnosis Dini dan Edukasi Pasien

Perawat memiliki peran sentral dalam:

- a. Skrining dan Konseling: Melakukan tes HIV dan memberikan konseling pra dan pasca tes untuk memastikan pemahaman pasien.
- b. Edukasi Pasien: Memberikan informasi tentang HIV, pentingnya terapi antiretroviral (ART), dan pencegahan penularan.
- c. Dukungan Psikososial: Membantu pasien mengatasi stigma dan diskriminasi, serta mendukung kesejahteraan mental mereka.

Studi menunjukkan bahwa intervensi yang dipimpin oleh perawat dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap ART dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Manajemen Terapi Antiretroviral (ART) oleh Perawat

Terapi antiretroviral (ART) adalah pengobatan utama untuk HIV, yang bertujuan menekan replikasi virus dan memulihkan fungsi imun. Perawat berperan dalam:

- a. Monitoring Terapi: Memantau efek samping, kepatuhan, dan efektivitas ART melalui pemeriksaan viral load dan jumlah sel CD4+.
- b. Edukasi dan Konseling: Memberikan informasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap ART dan cara mengelola efek samping.
- c. Koordinasi Layanan: Bekerja sama dengan tim multidisiplin untuk memastikan pasien menerima perawatan komprehensif.

Pendekatan yang dipimpin oleh perawat dalam manajemen ART telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil klinis dan kepatuhan pasien.

C. Pendekatan Multidisiplin dalam Perawatan HIV/AIDS

1. Definisi dan Komponen Tim Multidisiplin

Pendekatan multidisiplin dalam perawatan HIV/AIDS melibatkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan yang memiliki keahlian berbeda namun saling melengkapi, dengan tujuan memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi kepada pasien. Tim ini biasanya terdiri dari:

- a. Dokter: Bertanggung jawab atas diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi medis pasien.
- b. Perawat: Memberikan perawatan langsung, edukasi, dan dukungan emosional kepada pasien.

- c. Psikolog/Psikiater: Menyediakan layanan kesehatan mental untuk membantu pasien mengatasi stres, depresi, dan masalah psikologis lainnya yang terkait dengan HIV/AIDS.
- d. Pekerja Sosial: Membantu pasien dalam mengakses sumber daya sosial, seperti bantuan keuangan, perumahan, dan dukungan komunitas.
- e. Apoteker: Memberikan informasi tentang obat-obatan, memastikan kepatuhan terhadap terapi, dan mengelola interaksi obat.
- f. Ahli Gizi: Memberikan saran nutrisi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan umum pasien.

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kebutuhan pasien secara holistik dan penyediaan intervensi yang terkoordinasi, yang telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS.

2. Model Perawatan Terintegrasi di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengimplementasikan model perawatan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas perawatan HIV/AIDS:

- a. Ethiopia: Penerapan pendekatan tim perawatan multidisiplin di Jimma, Ethiopia, menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan, dengan fokus pada redistribusi tugas di antara anggota tim kesehatan. Frontline Health Workers Coalition
- b. Lesotho: Studi IMPROVE di Lesotho mengimplementasikan intervensi sistem kesehatan yang berpusat pada pasien untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan anak serta mengurangi transmisi HIV perinatal. BioMed Central
- c. India: Program Vihaan di India mendirikan dan mengelola 350 Pusat Perawatan & Dukungan (CSCs) untuk memperluas akses ke layanan penting, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan mengurangi

stigma serta diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.
Wikipedia

Model-model ini menekankan pentingnya integrasi layanan HIV dengan layanan kesehatan lainnya untuk menyediakan perawatan yang berpusat pada pasien dan berkelanjutan.

3. Peran Kolaboratif: Perawat, Dokter, Psikolog, Pekerja Sosial, dan Profesional Lainnya

Setiap anggota tim multidisiplin memiliki peran spesifik yang saling melengkapi:

- a. Perawat: Selain memberikan perawatan klinis, perawat juga berperan dalam edukasi pasien, konseling, dan koordinasi perawatan. Mereka sering menjadi penghubung antara pasien dan anggota tim lainnya.
- b. Dokter: Memimpin tim dalam aspek medis, termasuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien. Mereka juga bertanggung jawab atas penyesuaian terapi berdasarkan respons pasien.
- c. Psikolog/Psikiater: Menyediakan dukungan kesehatan mental, membantu pasien mengatasi stres, depresi, dan masalah psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan.
- d. Pekerja Sosial: Membantu pasien dalam mengakses sumber daya sosial, seperti bantuan keuangan, perumahan, dan dukungan komunitas, serta mengadvokasi hak-hak pasien.
- e. Apoteker: Memberikan informasi tentang obat-obatan, memastikan kepatuhan terhadap terapi, dan mengelola interaksi obat.
- f. Ahli Gizi: Memberikan saran nutrisi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan umum pasien.

Kolaborasi yang efektif di antara profesional ini memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berpusat pada kebutuhan individu mereka.

D. Intervensi Keperawatan dalam Tim Multidisiplin

1. Strategi Peningkatan Kepatuhan Terapi Antiretroviral (ART)

Kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ART) sangat penting untuk menekan replikasi virus HIV dan mencegah resistensi obat. Perawat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan pasien melalui:

- a. Edukasi Terstruktur: Memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ART dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.
- b. Konseling Individual dan Kelompok: Menyediakan ruang bagi pasien untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan. [Scribd+2mail.online-journal.unja.ac.id+2Scribd+2](mailto:online-journal.unja.ac.id)
- c. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan pengingat melalui pesan teks atau aplikasi untuk membantu pasien mengingat jadwal pengobatan. [ResearchGate+7RAMA](https://www.researchgate.net/publication/351714147) Universitas Malikussaleh+7bookchapter.optimalbynfc.com+7

Studi menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan dukungan sosial dan edukasi dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap ART. [mail.online-journal.unja.ac.id](mailto:online-journal.unja.ac.id)

2. Pendekatan Psikososial dan Dukungan Emosional

Pasien dengan HIV/AIDS sering menghadapi tantangan psikososial seperti stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial. Perawat dapat memberikan dukungan melalui:

- a. **Konseling Psikososial:** Membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan depresi yang terkait dengan diagnosis dan pengobatan.
- b. **Dukungan Keluarga:** Melibatkan keluarga dalam proses perawatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.
- c. **Pemberdayaan Pasien:** Mendorong pasien untuk aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. *Scribd+1Global Health Science Journal+1*

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang kuat berkontribusi pada peningkatan harga diri dan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS. *proceeding.unisayogya.ac.id*

3. Manajemen Nyeri dan Perawatan Paliatif

Manajemen nyeri dan perawatan paliatif penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS, terutama pada tahap lanjut penyakit. Perawat berperan dalam:

- a. **Penilaian Nyeri:** Menggunakan alat penilaian nyeri untuk mengidentifikasi tingkat dan jenis nyeri yang dialami pasien.
- b. **Intervensi Farmakologis dan Non-Farmakologis:** Memberikan obat pereda nyeri dan terapi alternatif seperti relaksasi atau terapi musik. *Kumaran*
- c. **Koordinasi Tim Paliatif:** Bekerja sama dengan tim multidisiplin untuk menyediakan perawatan yang holistik dan berpusat pada pasien.

Studi menunjukkan bahwa perawatan paliatif yang efektif dapat mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS. *Kumaran*

4. Konseling Nutrisi dan Dukungan Gizi

Status gizi yang baik penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh pasien dengan HIV/AIDS. Perawat dapat membantu melalui:

- a. **Konseling Gizi:** Memberikan informasi tentang pola makan sehat dan kebutuhan nutrisi khusus bagi pasien.
- b. **Pemantauan Status Gizi:** Melakukan penilaian berkala terhadap berat badan, indeks massa tubuh, dan asupan nutrisi pasien.
- c. **Kolaborasi dengan Ahli Gizi:** Bekerja sama untuk merancang rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa konseling gizi yang efektif dapat meningkatkan asupan energi dan status gizi pasien dengan HIV/AIDS.

E. Studi Kasus dan Implementasi Praktik

1. Implementasi Pendekatan Multidisiplin di Fasilitas Kesehatan

Pendekatan multidisiplin dalam perawatan HIV/AIDS telah diimplementasikan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, dengan melibatkan kolaborasi antara dokter, perawat, ahli gizi, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya. Contohnya, di DKI Jakarta, program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan untuk mencegah penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik. Integrasi ini mencakup koordinasi antara Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan puskesmas, serta dukungan dari lembaga internasional seperti Global Fund. NelitiUndip E-Journal System Portal+1Neliti+1

Di Kota Semarang, pendekatan multidisiplin diterapkan melalui program Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang melibatkan tenaga kesehatan, LSM, dan komunitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma, dan memperluas akses layanan HIV/AIDS. Undip E-Journal System Portal

2. Studi Kasus Keberhasilan dan Tantangan di Berbagai Wilayah

Studi kasus di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan keberhasilan dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui pendekatan multidisiplin. Program yang

melibatkan 18 layanan HIV, 17 layanan TB-HIV, dan strategi penjangkauan virtual berhasil meningkatkan cakupan layanan dan memetakan petugas lapangan untuk menjangkau klien di daerah terpencil. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesulitan dalam merekrut relawan dari kalangan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang telah sembuh. spekham.org

Di DKI Jakarta, integrasi program LASS ke dalam sistem kesehatan menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan pendanaan. Meskipun demikian, pendekatan ini berhasil meningkatkan efektivitas pencegahan HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik. Neliti+1kebijakanidsindonesia.net+1

3. Pembelajaran dari Praktik Terbaik (Best Practices)

Beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi dari implementasi pendekatan multidisiplin di berbagai wilayah antara lain:

- a. Praktik-praktik ini telah Integrasi Layanan: Menggabungkan layanan HIV/AIDS dengan layanan kesehatan lainnya untuk memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi.
- b. Pelibatan Komunitas: Melibatkan ODHA dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas intervensi.
- c. Pendekatan Berbasis Data: Menggunakan data epidemiologi dan surveilans untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- d. Kolaborasi Multisektor: Membangun kemitraan antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat respons terhadap HIV/AIDS.

terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan, mengurangi stigma, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

F. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Multidisiplin

1. Hambatan Struktural dan Sistemik

Pendekatan multidisiplin dalam perawatan HIV/AIDS di Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural dan sistemik yang menghambat efektivitas layanan. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

- a. Desentralisasi Sistem Kesehatan: Desentralisasi menyebabkan variasi dalam implementasi kebijakan dan program HIV/AIDS di tingkat daerah, yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan layanan dan kesenjangan dalam akses perawatan.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas: Kekurangan tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas yang memadai, terutama di daerah terpencil, menghambat penyediaan layanan HIV/AIDS yang berkualitas.
- c. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga terkait menyebabkan duplikasi program dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan sistem kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

2. Stigma dan Diskriminasi dalam Layanan Kesehatan

Stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menjadi tantangan signifikan dalam layanan kesehatan di Indonesia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stigma dan diskriminasi meliputi:

- a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman: Tenaga kesehatan dan masyarakat umum sering kali memiliki pemahaman yang terbatas tentang HIV/AIDS, yang dapat menyebabkan ketakutan dan prasangka negatif terhadap ODHA.

- b. Norma Sosial dan Budaya: Keyakinan budaya dan norma sosial tertentu dapat memperkuat stigma terhadap ODHA, menganggap mereka sebagai individu yang melakukan perilaku menyimpang atau tidak bermoral.
- c. Pengalaman Diskriminatif di Fasilitas Kesehatan: ODHA sering mengalami perlakuan diskriminatif di fasilitas kesehatan, seperti penolakan layanan atau pelanggaran privasi, yang dapat menghambat akses mereka terhadap perawatan yang diperlukan.

Upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi harus mencakup pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, kampanye kesadaran masyarakat, dan penegakan kebijakan anti-diskriminasi di fasilitas kesehatan. Jurnal Poltekesos

3. Strategi Penguatan Kapasitas Tim dan Pelatihan Berkelanjutan

Penguatan kapasitas tim multidisiplin dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan HIV/AIDS. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Pelatihan Terpadu: Mengembangkan program pelatihan yang mencakup aspek klinis, psikososial, dan manajerial untuk semua anggota tim multidisiplin.
- b. Supervisi dan Mentoring: Menerapkan sistem supervisi dan mentoring untuk mendukung pengembangan profesional dan memastikan penerapan praktik terbaik dalam perawatan HIV/AIDS.
- c. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan sumber daya pendidikan, pelatihan daring, dan platform kolaborasi antar profesional kesehatan.

Implementasi strategi ini dapat meningkatkan kompetensi tim multidisiplin, memperkuat koordinasi antar anggota tim, dan memastikan keberlanjutan layanan HIV/AIDS yang berkualitas.

G. Penutup

Rekomendasi dan Arah Kebijakan

1. Kebijakan Kesehatan yang Mendukung Pendekatan Multidisiplin

Pendekatan multidisiplin dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia telah mendapatkan dukungan melalui berbagai kebijakan kesehatan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS), yang menekankan pentingnya integrasi layanan dan koordinasi antar sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pasca UMI+3Database Peraturan | JDIH BPK+3Jurnal STIKes Kesdam IV Diponegoro+3

Selain itu, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS 2020–2024 juga menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk mencapai target eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. hivaids-pimsindonesia.or.id

Strategi ini sejalan dengan pendekatan global yang diusung oleh UNAIDS dalam Strategi AIDS Global 2021–2026, yang menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral dan penguatan sistem kesehatan untuk mengakhiri epidemi AIDS. UNAIDS

2. Peran Pendidikan Keperawatan dalam Mempersiapkan Perawat untuk Kolaborasi

Pendidikan keperawatan memainkan peran krusial dalam mempersiapkan perawat untuk berkolaborasi dalam tim multidisiplin. Implementasi Pendidikan Interprofesi (Interprofessional Education/IPE) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi kolaboratif perawat, yang meliputi komunikasi antarprofesi, pemahaman peran, dan kerja tim. ResearchGate

Institusi pendidikan keperawatan di Indonesia mulai mengintegrasikan IPE dalam kurikulum mereka. Sebagai contoh, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta telah menyelenggarakan kuliah pakar yang melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk membahas kolaborasi dalam pelayanan HIV/AIDS, yang bertujuan untuk membangun ekosistem multidisiplin dalam mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. [ResearchGate.gunabangsa.ac.id](https://researchgate.gunabangsa.ac.id)

Penguatan pendidikan keperawatan melalui IPE dapat meningkatkan kesiapan perawat dalam berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan HIV/AIDS.

3. Arah Penelitian dan Inovasi di Masa Depan

Penelitian dan inovasi merupakan komponen penting dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Beberapa arah penelitian dan inovasi yang dapat dikembangkan di masa depan antara lain:

- a. Penggunaan Teknologi Informasi dan Kecerdasan Buatan: Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam prediksi penyebaran HIV/AIDS dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya, penelitian di Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode regresi linier berganda untuk memprediksi peningkatan kasus HIV/AIDS, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- b. Pengembangan Terapi Baru: Penelitian mengenai penggunaan antibodi penetralisir luas (bNAbs) sebagai alternatif terapi antiretroviral menunjukkan potensi dalam menekan replikasi virus HIV. Kombinasi bNAbs dapat dirancang secara optimal untuk mencegah pelarian virus dan meningkatkan efektivitas terapi. [arXiv](https://arxiv.org/)
- c. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan: Penelitian mengenai hambatan dalam akses layanan HIV/AIDS, seperti stigma dan diskriminasi, serta pengembangan strategi untuk mengatasinya, tetap menjadi fokus

penting. Selain itu, inovasi dalam model layanan, seperti layanan berbasis komunitas dan telemedisin, dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendidikan keperawatan yang adaptif, dan penelitian serta inovasi yang berkelanjutan, pendekatan multidisiplin dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dapat diperkuat untuk mencapai target eliminasi pada tahun 2030.

Referensi

- Apriliana, F. (2024). Hubungan dukungan keluarga dengan harga diri orang dengan HIV/AIDS. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 884–886.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). About HIV. Diakses dari <https://www.cdc.gov/hiv/about/index.html>
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2019). Profil Kesehatan Kota Semarang. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/32649/26202>
- Health Information: Jurnal Penelitian. (2024). Stigma dan diskriminasi sosial terhadap pengidap HIV-AIDS. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 5(1), 1–7.
- Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). (2021). Strategi Global AIDS 2021–2026: Mengakhiri ketidaksetaraan, mengakhiri AIDS. Diakses dari https://www.unaids.org/sites/default/files/media/documents/global-AIDS-strategy-2021-2026_id.pdf
- Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). (2023). Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet. Diakses dari <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>
- Jurnal Ilmiah Kesehatan. (2021). Pengetahuan tentang HIV/AIDS dan diskriminasi terhadap ODHA pada wanita usia subur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(3), 203–210.
- Jurnal Keperawatan STIKES Kendal. (2023). Stigma diskriminasi dan dampaknya terhadap kesediaan merawat pasien HIV/AIDS. *Jurnal Keperawatan STIKES Kendal*, 9(2), 120–128.
- Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia. (2024). Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA di layanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 15(1), 34–42.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Perkembangan HIV/AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) di Indonesia Triwulan II Tahun 2023. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Diakses dari https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TWII_2023.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Program pengendalian HIV/AIDS dan PIMS. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Diakses dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/301566/Permenkes%20Nomor%2023%20Tahun%202022.pdf>

- Kusdiyah, E., et al. (2024). Edukasi berkelompok untuk peningkatan kepatuhan terapi ARV pada ODHA. *MEDIC*, 7(2), 104–109.
- Mabunda, M. M., & Khoza, L. B. (2022). Multidisciplinary approach interventions on adherence to antiretroviral therapy among people living with HIV/AIDS: A systematic review. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 17, 100462. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2022.100462>
- Nurseslabs. (2023). HIV and AIDS nursing care management and study guide. Diakses dari <https://nurseslabs.com/hiv-aids/>
- Pusat Kajian Manajemen Kesehatan FK UGM. (2019). Studi kasus: Integrasi respon HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan dan efektivitas program LASS di DKI Jakarta. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/45306-ID-studi-kasus-integrasi-respon-hiv-dan-aids-ke-dalam-sistem-kesehatan-dan-efektivi.pdf>
- Shaluhiah, Z., Musthofa, S. B., & Indrayathi, P. A. (2021). Peran perawat dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien HIV/AIDS melalui pendekatan konseling. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 9(2), 115–123. <https://doi.org/10.32584/jkk.v9i2.2038>
- SPEK-HAM. (2019). SPEK-HAM paparkan best practice dalam program penjangkauan HIV dan AIDS. Diakses dari <https://www.spekham.org/spekham-paparkan-best-practice-dalam-program-penjangkauan-hiv-dan-aids/>
- Thobias, E. I., & Mulyadi, M. (2022). Kolaborasi interprofesi dalam manajemen perawatan pasien HIV/AIDS: Sebuah tinjauan naratif. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 10(1), 32–40. <https://doi.org/10.33086/jik.v10i1.2887>
- Wardani, E., Setyoadi, S., & Astuti, E. R. (2021). Stigma terhadap ODHA: Tantangan dalam pelayanan kesehatan dan peran perawat sebagai advokat. *Jurnal Ners*, 16(2), 225–231. <https://doi.org/10.20473/jn.v16i2.25309>
- Yuliana, Y., & Indarwati, R. (2023). Strategi edukasi berbasis keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC)*, 8(1), 30–39. <https://doi.org/10.24990/injec.v8i1.468>
- Yuniarti, Y., Purba, M. B., & Pangastuti, R. (2019). Pengaruh konseling gizi dan penambahan makanan terhadap asupan zat gizi dan status gizi pasien HIV/AIDS. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 9(3), 132–138.

Profil Penulis



Ns. Nyoman Agus Jagat Raya, S.Kep., MNS.

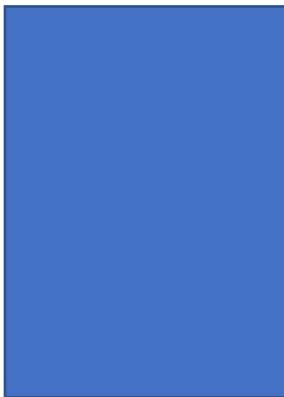
lahir di Denpasar pada 10 Maret 1991, adalah seorang dosen Lektor bidang Keperawatan Medikal Bedah di Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana. Penulis menempuh pendidikan S1 dan Profesi Ners di Universitas Udayana dan melanjutkan studi S2 Master of Nursing Science (International Program) di Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Thailand dengan thesisnya yang telah terpublikasi pada Scopus Q2 dengan judul Experience and management of stigma among persons living with HIV in Bali, Indonesia: A descriptive study. Karya tersebut juga pernah dipresentasikan dihadapan Wakil Menteri Kesehatan RI pada tahun 2021. Selain aktif menulis artikel ilmiah, buku, dan publikasi serta menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan topik penelitian di bidang HIV-AIDS, salah satunya program hibah pengabdian masyarakat kepada komunitas tuli di Desa Bengkala, Buleleng untuk mengedukasi pencegahan HIV dan AIDS tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jagatraya91@unud.ac.id



Ns. Rian Maulana Yusup, S.Kep., M.Kep



Bd. Iryani Yuni Yastutik, SST., M.Kes.



Firmina Theresia Kora., S.Kep.Ns., M.P.H.

Sinopsis

Buku referensi "Peran Keperawatan dalam Perawatan Pasien dengan HIV/AIDS" merupakan panduan penting yang menghadirkan tinjauan lengkap mengenai peran strategis keperawatan dalam mengelola pasien dengan HIV/AIDS. Buku ini menjelaskan berbagai strategi keperawatan untuk menjaga kualitas hidup pasien, termasuk pendekatan terhadap stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Stigma ini sering kali menjadi hambatan utama dalam akses layanan kesehatan yang diperlukan pasien.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang dukungan psikologis yang penting bagi pasien HIV/AIDS dan keluarganya. Pasien dengan HIV/AIDS tidak hanya membutuhkan perawatan medis, tetapi juga dukungan emosional yang kuat agar mampu menghadapi tekanan psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Dukungan keluarga dan mekanisme koping yang tepat juga menjadi aspek penting yang dibahas secara detail.

Selain itu, buku ini juga menyoroti peran vital komunitas dalam mendukung pasien HIV/AIDS. Komunitas memiliki kekuatan besar dalam mengurangi stigma, meningkatkan deteksi dini, mendorong kepatuhan pengobatan, dan memberikan dukungan psikososial yang efektif. Studi kasus dari berbagai negara yang disajikan dalam buku ini memberikan contoh nyata tentang keberhasilan pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Terakhir, pendekatan multidisiplin yang dijelaskan dalam buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan seperti dokter, perawat, psikolog, ahli gizi, dan pekerja sosial. Dengan pendekatan ini, pasien akan menerima perawatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Buku ini merupakan sumber referensi penting yang akan sangat bermanfaat bagi praktisi keperawatan, akademisi, serta semua pihak yang peduli terhadap peningkatan layanan kesehatan pasien HIV/AIDS.

Buku referensi "Peran Keperawatan dalam Perawatan Pasien dengan HIV/AIDS" merupakan panduan penting yang menghadirkan tinjauan lengkap mengenai peran strategis keperawatan dalam mengelola pasien dengan HIV/AIDS. Buku ini menjelaskan berbagai strategi keperawatan untuk menjaga kualitas hidup pasien, termasuk pendekatan terhadap stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Stigma ini sering kali menjadi hambatan utama dalam akses layanan kesehatan yang diperlukan pasien.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang dukungan psikologis yang penting bagi pasien HIV/AIDS dan keluarganya. Pasien dengan HIV/AIDS tidak hanya membutuhkan perawatan medis, tetapi juga dukungan emosional yang kuat agar mampu menghadapi tekanan psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Dukungan keluarga dan mekanisme coping yang tepat juga menjadi aspek penting yang dibahas secara detail.

Selain itu, buku ini juga menyoroti peran vital komunitas dalam mendukung pasien HIV/AIDS. Komunitas memiliki kekuatan besar dalam mengurangi stigma, meningkatkan deteksi dini, mendorong kepatuhan pengobatan, dan memberikan dukungan psikososial yang efektif. Studi kasus dari berbagai negara yang disajikan dalam buku ini memberikan contoh nyata tentang keberhasilan pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS.

Terakhir, pendekatan multidisiplin yang dijelaskan dalam buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan seperti dokter, perawat, psikolog, ahli gizi, dan pekerja sosial. Dengan pendekatan ini, pasien akan menerima perawatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Buku ini merupakan sumber referensi penting yang akan sangat bermanfaat bagi praktisi keperawatan, akademisi, serta semua pihak yang peduli terhadap peningkatan layanan kesehatan pasien HIV/AIDS.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-8-2



9

786238

997282